



Nur zur dienstlichen Verwendung

Dieser Vermerk verliert seine Gültigkeit mit der Veröffentlichung des Protokolls gemäß § 73 GOBT, spätestens jedoch nach Ablauf der jeweils nachfolgenden Wahlperiode.

Veröffentlicht am: 24.02.2026

Kurzprotokoll der 13. Sitzung

Ausschuss für Gesundheit

Berlin, den 15. Oktober 2025, 09:30 Uhr
als Kombination aus Präsenzsitzung
(Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Saal 3 101) und
Zoom-Meeting.

Vorsitz: Dr. Tanja Machalet, MdB
Dr. Stephan Pilsinger, MdB

Tagesordnung



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 1

Seite 7

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 – HG 2026)

BT-Drucksache 21/600

Federführend:

Haushaltsausschuss

Gutachtlich:

Innenausschuss

Ausschuss für Sport und Ehrenamt

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Verteidigungsausschuss

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Ausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Ausschuss für Tourismus

Ausschuss für Kultur und Medien

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Tagesordnungspunkt 2

Seite 9

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Beschleunigung der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Eckpunktepapier zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen aus dem Jahr 2023

BT-Drucksache 21/1746

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung

Haushaltsausschuss

Tagesordnungspunkt 3

Seite 9

Gesetzentwurf der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des § 65d Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

BT-Drucksache 21/1548

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Haushaltsausschuss



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 4

Seite 9

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Digitalisierung und Bürokratieabbau im Gesundheitswesen – Effiziente Versorgung durch strukturelle Reformen stärken

BT-Drucksache 21/1751

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung
Haushaltsausschuss

Tagesordnungspunkt 5

Seite 9

Antrag der Abgeordneten Dr. Armin Grau, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonthier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Medizinische Versorgungszentren reformieren

BT-Drucksache 21/1667

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen

Tagesordnungspunkt 6

Seite 10

Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen

Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2023 – Prüfung und Bewertung der Emissionsdaten

BT-Drucksache 21/770

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss

Tagesordnungspunkt 7

Seite 10

Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen

Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2024 und zu den Projektionsdaten 2025 – Prüfung und Bewertung der Emissionsdaten sowie der Projektionsdaten

BT-Drucksache 21/810

Federführend:

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mitberatend:

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat

Ausschuss für Gesundheit

Verkehrsausschuss



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 8 **Seite 10**

Fachgespräch "Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen"

Selbstbefassung S-21(14)23

Tagesordnungspunkt 9 **Seite 16**

Fachgespräch zur HNO-Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Selbstbefassung S-21(14)25

Tagesordnungspunkt 10 **Seite 23**

a) **Gesetzentwurf der Bundesregierung**

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neupsychoaktive-Stoffe-Gesetzes

BT-Drucksache 21/1504

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

b) **Unterrichtung durch die Bundesregierung**

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neupsychoaktive-Stoffe-Gesetzes

- 21/1504 -

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

BT-Drucksache 21/1927

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Tagesordnungspunkt 11 **Seite 23**

Nachbericht zur Sitzung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) (Formation Gesundheit) am 20. Juni 2025 in Luxemburg

Selbstbefassung S-21(14)12



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 12

Seite 24

Nachbericht des Bundesministeriums für Gesundheit zum Informellen Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und EU-Gesundheitsminister am 15. und 16. September 2025 in Kopenhagen, Dänemark

Selbstbefassung S-21(14)24

Tagesordnungspunkt 13

Seite 8

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege

BT-Drucksache 21/1511

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Anne Janssen [CDU/CSU]
Abg. N. N. [AfD]
Abg. Claudia Moll [SPD]
Abg. Simone Fischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Evelyn Schötz [Die Linke]

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege
- 21/1511 -**

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

BT-Drucksache 21/1935

Federführend:

Ausschuss für Gesundheit

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales
Haushaltsausschuss

Berichterstatter/in:

Abg. Anne Janssen [CDU/CSU]
Abg. N. N. [AfD]
Abg. Claudia Moll [SPD]
Abg. Simone Fischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Evelyn Schötz [Die Linke]

Tagesordnungspunkt 14

Seite 7

Beschlussfassung, die Sitzungszeit der nichtöffentlichen Ausschusssitzung am 5. November 2025 auf 11 Uhr bis maximal 14:30 Uhr zu verschieben



Nur zur dienstlichen Verwendung

Mitglieder des Ausschusses

Fraktionen	Ordentliche Mitglieder	Stellvertretende Mitglieder
CDU/CSU	Beek, Sascha van Borchardt, Simone Hiller, Dr. Matthias Janssen, Anne Müller, Axel Pauls, Dr. Thomas Pilsinger, Dr. Stephan Schmidt, Sebastian Seitz, Nora Streeck, Dr. Hendrik Theiss, Dr. Hans Weiss, Dr. Maria-Lena Zeulner, Emmi	Albani, Stephan Demuth, Ellen Ehm, Lars Grasse, Adrian Knoerig, Axel Ludwig, Dr. Saskia Müller, Sepp Reddig, Pascal Rupprecht, Albert Staffler, Katrin Stegemann, Albert Timmermann-Fechter, Astrid Walch, Siegfried
AfD	Baum, Dr. Christina Bloch, Joachim Dietz, Thomas Ebenberger, Tobias Hess, Nicole Schießl, Carina Sichert, Martin Weiss, Claudia Ziegler, Kay-Uwe	Bessin, Birgit Birghan, Dr. Christoph Bollmann, Gereon Fetsch, Thomas Giersch, Alexis L. Kempf, Martina Möller, Stefan Przygodda, Kerstin Schmidt, Dr. Paul
SPD	Machalet, Dr. Tanja Mieves, Matthias David Moll, Claudia Pantazis, Dr. Christos Schwartz, Stefan Seitzl, Dr. Lina Yüksel, Serdar	Ahmetovic, Adis Dittmar, Sabine Glöckner, Angelika Kersten, Dr. Franziska Peick, Jens Schmidt, Dagmar
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Dahmen, Dr. Janosch Fischer, Simone Heitmann, Linda Kappert-Gonther, Dr. Kirsten Wagner, Johannes	Grau, Dr. Armin Nick, Dr. Ophelia Piechotta, Dr. Paula Rietenberg, Sylvia
Die Linke	Gürpinar, Ates Merendino, Stella Schötz, Evelyn Stange, Julia-Christina	Arndt, Dr. Michael Brückner, Maik Fey, Katrin Gebel, Kathrin



Nur zur dienstlichen Verwendung

Liste der Auskunftspersonen

Fachgespräch „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS:
Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle
Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“
am Mittwoch, 15. Oktober 2025

1. **PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger**
Universitätsklinikum Erlangen
2. **Sebastian Musch** (online)
Deutsche Gesellschaft für ME/CFS
3. **Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen**
Charité – Universitätsmedizin Berlin
4. **Daniel Vilser** (online)
Ärzte- und Ärztinnenverband Long COVID
5. **Long COVID Deutschland**
Simon Schöning



Nur zur dienstlichen Verwendung

Liste der Auskunftspersonen

Fachgespräch zur HNO-Versorgung von Kindern und Jugendlichen
am Mittwoch, 15. Oktober 2025

- **Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.**
Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler
- **Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V.**
Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg
- **GKV-Spitzenverband**
Stephan Feldmann
- **Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)**
Florian Schönberg
- **Christian Hartnik** (online)
Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffelstein



Nur zur dienstlichen Verwendung

Die Anwesenheitslisten liegen dem Originalprotokoll bei.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Beginn der Sitzung: 9:30 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Die **Vorsitzende**, Abg. **Dr. Tanja Machalet** (SPD), führt aus, dass die Tagesordnungspunkte 13 und 14 neu aufgesetzt worden seien. Tagesordnungspunkt 14 werde sie gleich nach Eintritt in die Tagesordnung aufrufen. Die Fraktion der AfD habe in der Obleute-Besprechung angekündigt zu prüfen, ihren Antrag auf Tagesordnungspunkt 3 gegebenenfalls zurückzuziehen. Sie gibt bekannt, dass Abg. Dr. Weiss, Abg. Janssen und Abg. Schwartze mit Rede- und Stimmrecht online teilnähmen.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) erklärt, an Tagesordnungspunkt 3 festzuhalten.

Die **Vorsitzende** teilt mit, die Sitzungsleitung ab 12:00 Uhr an ihren Stellvertreter, Abg. Dr. Pilsinger, abgeben zu müssen. Sie stellt die Tagesordnung fest.

Tagesordnungspunkt 14

Beschlussfassung, die Sitzungszeit der nichtöffentlichen Ausschusssitzung am 5. November 2025 auf 11:00 Uhr bis maximal 14:30 Uhr zu verschieben

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion Die Linke, die Sitzungszeit der nichtöffentlichen Ausschusssitzung am 5. November 2025 auf 11:00 Uhr bis maximal 14:30 Uhr zu verschieben.

Tagesordnungspunkt 1

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 – HG 2026)

BT-Drucksache 21/600

Abg. **Dr. Paula Piechotta** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt die acht Änderungsanträge ihrer Fraktion auf Ausschussdrucksache 21(14)30¹ ein.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) führt aus, der Gesundheitsetat 2026 stehe für Stabilität und Zukunftsfähigkeit, wobei der Schwerpunkt auf Strukturreformen statt auf kurzfristigen Krisenprogrammen liege. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf rund 20 Milliarden Euro, das seien 789 Millionen Euro mehr als 2025, womit der Etat drittgrößter Einzelplan nach dem Sozial- und Verteidigungshaushalt bleibe. Zentrale Schwerpunkte seien Pflege und Solidarität, was Zuschüsse in Form von Darlehen an die soziale Pflegeversicherung zur Stabilisierung der Beitragssätze bedeute. Gleichzeitig müsse die Finanzierungsstabilität ohne Leistungsabbau das Ziel sein. Im Hinblick auf Gesundheitsfonds und GKV-Stabilisierung gehe es um die Fortführung der Bundeszuschüsse auf gleichbleibendem Niveau, um die gesetzliche Krankenversicherung zu stärken. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens berücksichtige den Ausbau der Telemedizininfrastruktur und der elektronischen Patientenakte sowie die Förderung der Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungs- und Versorgungszwecken. Zur Versorgungssicherheit bei Arzneimitteln seien Mittel für die Resilienz der Lieferketten, Produktionsanreize in der EU und als Krisenreserven hinterlegt, wobei die Schwerpunkte auf Arzneimittelsicherheit und Medizinprodukteverfügbarkeit lägen. Gleichzeitig finde eine Modernisierung der Verwaltung statt, wobei eine verstärkte Förderung der nachgeordneten Bundesinstitute, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Forschung und Krisenmanagement vorgenommen werde. Der Haushalt setze auf Planbarkeit und Verantwortung. Jeder Euro diene der Versorgungssicherheit, Digitalisierung und Stabilität des Systems.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) betont, die versicherungsfremden Leistungen, die pauschal mit 14,5 Milliarden Euro bezuschusst würden, müssten auf eine sichere Basis gehoben werden. Zudem müsse man sich ehrlich machen, welche versicherungsfremden Leistungen in der Krankenversicherung finanziert

¹ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)30



Nur zur dienstlichen Verwendung

würden. Dies sollte über Steuermittel geschehen, was im vorliegenden Entwurf noch lange nicht ausreichend berücksichtigt sei. Weiterhin sei ein Reformbedarf bei den Krankenkassenbeiträgen vorhanden, da die Gefahr bestehe, dass die Krankenkassenbeiträge und Zusatzbeiträge bei Fortführung der aktuellen Politik um bis zu 4 Prozent ansteigen könnten, was eine Erhöhung der Lohnnebenkosten und der Kosten für die Versicherten bedeute. Hier seien Strukturreformen notwendig. Die Krankenhausfinanzierung aus dem Sondervermögen werde abgelehnt, weil die Mittel nicht zielgerichtet eingesetzt würden. Es seien noch viele größere Reformen auf den Weg zu bringen, weswegen der Gesetzentwurf abgelehnt werde.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) führt aus, der Entwurf des Bundeshaushalts 2026 umfasse für den Etat des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) Gesamtausgaben von rund 20,1 Milliarden Euro. Der größte Posten sei der Steuerzuschuss für die gesetzliche Krankenversicherung in Höhe von 14,5 Milliarden Euro zur pauschalen Abgeltung der Aufwendung der Krankenkassen für gesamtgesellschaftliche Aufgaben. Angesichts steigender Ausgaben und struktureller Defizite reiche dies jedoch nicht aus. Es bedürfe tiefgreifender Strukturreformen, um das Gesundheitswesen zukunftsfest zu machen, welche die Koalition nun gemeinsam anpacken werde. Sie sei froh über die produktiven, konstruktiven Gespräche und darüber, dass in den kommenden Wochen einige Vorhaben im Deutschen Bundestag zur Beschlussfassung gelangten.

Abg. **Dr. Paula Piechotta** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) begrüßt, dass insbesondere auch von der Koalition die Stärkung der Präventionstitel insbesondere der Drogen- und Suchtprävention sowie der Prävention im Bereich Suizid unterstützt werde. Es liege seit Langem eine parlamentarische Initiative vor, die es aus Respekt vor dem Parlament und angesichts des mit Sucht verbundenen Leides verdiene, nun endlich umgesetzt zu werden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) müsse auskömmlich ausgestattet werden, wenn es die angedachten zusätzlichen Aufgaben nicht nur übernehmen, sondern auch meistern solle.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) erklärt, der

Einzelplan 15 sei irgendetwas zwischen unambitioniert und einem Beitrag dafür, dass die öffentliche Daseinsvorsorge „vor die Hunde“ gehe. Es fehle weiterhin eine Dynamisierung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Krankenversicherung, dessen Anteil mittlerweile halb so hoch sei wie vor 15 Jahren. Das Versprechen beider Parteien vor der Wahl, die Beiträge der Bürgergeldbeziehenden aus Steuermitteln zu finanzieren, werde nicht eingelöst. Grundsätzlich fehle ein Beitrag zur Versorgungsstruktur im Land. Hinsichtlich der Erforschung von seltenen Krankheiten wie Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) seien mehr Mittel erforderlich. Ungefähr 600 000 Menschen seien betroffen und warteten auf Unterstützung. Bereits Bundesminister Prof. Dr. Lauterbach habe seinerzeit gesagt, dass eine Milliarde Euro dafür nötig seien. Der Betrag hierfür und für andere seltene Krankheiten liege jedoch ungefähr bei lediglich 150 Millionen Euro. Es werde mehr Geld benötigt, um den Menschen gerecht zu werden, die nach der Pandemie unter den Folgen litten, wozu die Koalition nicht beitrage. Deswegen werde der Haushalt 2026 abgelehnt.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Änderungsanträge auf Ausschussdrucksache 21(14)30 abzulehnen.

Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, dem Plenum des Deutschen Bundestages die Annahme des Haushaltsgesetzes auf Drucksache 21/600 zu empfehlen.

Tagesordnungspunkt 13

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege

BT-Drucksache 21/1511



Nur zur dienstlichen Verwendung

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Befugnisserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege - 21/1511 - Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

BT-Drucksache 21/1935

Die **Vorsitzende** gibt bekannt, dass die Fraktionen der CDU/CSU und SPD planen, Änderungsanträge zum Gesetzentwurf vorzulegen. Zu diesen solle eine öffentliche Anhörung stattfinden.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu den angekündigten Änderungsanträgen zum Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1511, 21/1935 durchzuführen.

Die **Vorsitzende** sagt, die Anhörung sei für den 3. November 2025, 15:15 Uhr geplant. Davor würden die Änderungsanträge in einer Sondersitzung eingeführt.

Tagesordnungspunkt 2

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Beschleunigung der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Eckpunktepapier zum Bürokratieabbau im Gesundheitswesen aus dem Jahr 2023

BT-Drucksache 21/1746

Abg. **Nicole Hess** (AfD) führt den Antrag auf Drucksache 21/1746 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/1746 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 3

Gesetzentwurf der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des § 65d Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch

BT-Drucksache 21/1548

Abg. **Martin Sichert** (AfD) führt den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1548 ein.

Der Ausschuss lehnt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD die Durchführung einer öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1548 ab.

Tagesordnungspunkt 4

Antrag der Abgeordneten Martin Sichert, Dr. Christina Baum, Carina Schießl, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Digitalisierung und Bürokratieabbau im Gesundheitswesen – Effiziente Versorgung durch strukturelle Reformen stärken

BT-Drucksache 21/1751

Abg. **Claudia Weiss** (AfD) führt den Antrag auf Drucksache 21/1751 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/1751 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 5

Antrag der Abgeordneten Dr. Armin Grau, Dr. Janosch Dahmen, Dr. Kirsten Kappert-Gonthier, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Medizinische Versorgungszentren reformieren

BT-Drucksache 21/1667

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung und bittet um Auszählung



Nur zur dienstlichen Verwendung

der im Saal anwesenden Mitglieder. Die Mehrheit der Regierungskoalition sei fraglich.

Abg. **Matthias Mieves** (SPD) führt aus, dass Abg. Schwartz krankheitsbedingt mit Stimm- und Rederecht online teilnehme.

Abg. **Simone Borchardt** (CDU/CSU) ergänzt, dies gelte auch für die Abg. Dr. Weiss und Abg. Janssen.

Die **Vorsitzende** erläutert, auf die entschuldigte Abwesenheit und die Online-Teilnahme mit Rede- und Stimmrecht habe sie vor Eintritt in die Tagesordnung hingewiesen.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, ein Prozedere im Ausschuss sei notwendig, um die Stimmverhältnisse nicht nur grundsätzlich festzustellen. Es sei legitim, dass zugeschaltete, etwa kranke Abgeordnete abstimmen könnten, doch sei es schwierig, wenn man die Stimmverhältnisse im konkreten Fall nicht kenne.

Abg. **Dr. Christos Pantazis** (SPD) antwortet, er verstehe die Grundlage der Diskussion nicht, da zu Beginn mitgeteilt worden sei, dass die Kollegen digital zugeschaltet seien, was aus seiner Sicht ausreichend sei.

Abg. **Dr. Janosch Dahmen** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) entgegnet, die Mehrheiten seien zu den einzelnen Abstimmungen sicherzustellen. Das bedeute, wenn eine Mehrheit im Raum nicht gegeben sei, müsse gesagt werden, wer mit Abstimmungsrecht online dabei sei, damit die Mehrheit zu der einzelnen Abstimmung gewährleistet werde. Es funktioniere nicht, nur allgemein zu sagen, dass es aus Krankheitsgründen zugeschaltete Kollegen gebe.

Die **Vorsitzende** stellt fest, es bestehe jederzeit die Möglichkeit, bei angezweifelte Mehrheitsverhältnissen zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt eine Einzelauszählung zu beantragen. Wenn dies nicht erfolge, gehe sie davon aus, dass die Abstimmung so akzeptiert werde.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt den Antrag auf Drucksache 21/1667 ein.

Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, eine öffentliche Anhörung zu dem Antrag auf Drucksache 21/1667 durchzuführen.

Tagesordnungspunkt 6

Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen

Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2023 – Prüfung und Bewertung der Emissionsdaten

BT-Drucksache 21/770

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen auf Drucksache 21/770 einvernehmlich zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt 7

Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen

Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2024 und zu den Projektionsdaten 2025 – Prüfung und Bewertung der Emissionsdaten sowie der Projektionsdaten

BT-Drucksache 21/810

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung durch den Expertenrat für Klimafragen auf Drucksache 21/810 einvernehmlich zur Kenntnis.

Tagesordnungspunkt 8

Fachgespräch „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“

Selbstbefassung S-21(14)23

PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger (Universitätsklinikum Erlangen) erklärt, dass HbA1c ein heutzutage unverzichtbarer Marker in der Diagnostik und Therapie bei Diabetes sei, dessen Entdeckung ein Zufallsbefund in einer klinischen Studie gewesen sei. Der Entdecker habe diesen Befund nicht ignoriert, sondern in einer größeren Kohorte überprüft. Er habe daraufhin die



Nur zur dienstlichen Verwendung

Diagnostik so entwickelt, dass sie in der Klinik gut anwendbar sei. Weiterhin sei der Befund in einem anderen Labor validiert und die Methode genutzt worden, um die Reproduzierbarkeit der Resultate zu überprüfen. Der entscheidende Schritt zum Durchbruch dieses Biomarkers sei die Verbindung mit Therapiestudien gewesen, da sich Befunde nur dann mit der Krankheit in Verbindung bringen ließen, wenn sie sich unter einer spezifischen Therapie veränderten. Bezüglich Post-Covid und ME/CFS führt sie aus, dass schon vor der Pandemie Befunde zu ME/CFS und seit der Pandemie zu Long- und Post-Covid gegeben habe. Diese Einzelbefunde von Ärzten und Laboren habe man mit öffentlicher Unterstützung und Spenden relativ zügig in größeren Kohorten verifizieren können. Aktuell werde durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) unterstützte Forschung betrieben, um diese Biomarker und Biosignaturen weiter zu spezifizieren und die notwendigen Diagnostika zu entwickeln. Die Parallele zu Diabetes sei erkennbar und Therapiestudien seien notwendig, um die Biomarker und Biosignaturen zu verifizieren. Solche Studien würden einerseits Therapien für spezifische Untergruppen ermöglichen. Andererseits stünden dann die Therapien sowie die Biomarker und Biosignaturen als Diagnostika zur Verfügung, womit man sich von der derzeitigen zeit- und kostenaufwendigen Ausschlussdiagnostik abwenden könne.

Sebastian Musch (Deutsche Gesellschaft ME/CFS) betont, die Versorgungssituation von Menschen mit ME/CFS sei in Deutschland weiterhin sehr schlecht, da die Wege zur Diagnose extrem lang seien und die meisten Ärzte nicht wüssten, wie sie mit dem Krankheitsbild umgehen sollten. Obwohl klare, öffentlich zugängliche Empfehlungen für Diagnostik und Therapie existierten, seien diese im Gesundheitssystem und bei den Sozialträgern kaum bekannt und würden selten angewendet. Die Versorgungslücke sei das Ergebnis jahrzehntelanger Vernachlässigung und fehlender Aufklärung, was auch die Umsetzung der G-BA-Richtlinie zur Versorgung bei Long-Covid, Post-Covid, ME/CFS und ähnlichen Erkrankungen erschwere. Es fehlten spezialisierte Anlaufstellen und stationäre Behandlungsmöglichkeiten, weswegen die Pflege meist von Angehörigen übernommen werde. Nicht angepasste Begutachtungsrichtlinien führten zudem zur

Ablehnung von Leistungsansprüchen und zu finanzieller Armut. Notwendig sei eine umfassende Aufklärungskampagne, um das vorhandene Wissen anzuwenden und den Erkrankten zumindest eine Stabilisierung, Symptomlinderung und Absicherung zu ermöglichen. Die Erforschung medikamentöser Therapien sei von zentraler Bedeutung für die Versorgung, da nur wirksame Medikamente den Zustand der Erkrankten nachhaltig verbessern könnten. Die Nationale Klinische Studiengruppe (NKSG) setze hier an, da sie weltweit einmalig die Therapieforschung und Medikamentenerprobung direkt mit einer Diagnostik- und Biomarkerplattform verbinde und internationale Maßstäbe setze. Es sei notwendig, für eine umfassende Aufklärung und Fortbildung zu sorgen, die Finanzierung der NKSG zu sichern und Mittel für die Entwicklung wirksamer Therapien freizugeben.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité – Universitätsmedizin Berlin) schließt sich den Ausführungen zur Versorgung an und erwähnt die seinerzeit von Bundesminister Prof. Dr. Lauterbach angestoßenen G-BA-Richtlinien zur Versorgung mit neuen EBM-Ziffern (Einheitlicher Bewertungsmaßstab), deren Umsetzung in der Fläche jedoch unzureichend sei, wobei insbesondere Fachambulanzen fehlten. Ein weiteres Problem sei die oft fehlende Anerkennung, dass es sich um eine schwere, chronische Erkrankung handle, die nicht durch Psychotherapie und psychosomatische Rehabilitation behandelbar sei. Aktuelle Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung belegten, dass Long-Covid und ME/CFS unzureichend und nicht adäquat abgebildet würden, was zur oft fehlenden Anerkennung von Krankheitsschwere, Pflegegrad und Erwerbsunfähigkeit führe. Zur Medikamentenentwicklung sei festzuhalten, dass bislang keine ursächlich wirksamen Medikamente existierten. Eine symptomorientierte Behandlung habe an der Krankheitsschwere und Arbeitsfähigkeit nichts geändert, was den zentralen Bedarf an therapeutischen Studien belege, die an den biologischen Ursachen ansetzten und rasch vorangetrieben werden müssten. Sie berichtet von einem bereits 2021 vorgelegten Konzept für eine mechanismenbasierte Therapieentwicklung unter Einsatz zugelassener Medikamente, begleitet von umfassenden Biomarkerstudien. Trotz der im Jahr 2022 vom Bundesministerium für Bildung und



Nur zur dienstlichen Verwendung

Forschung (BMBF) erhaltenen zehn Millionen Euro und dem Aufbau einer Plattform sowie initiierten Therapiestudien, seien die für Folge-Medikamentenstudien im Haushalt 2024 bereitgestellten acht Millionen Euro bis heute nur zu einem kleinen Teil angekommen. Dies verhindere seit einem Jahr die Initiierung dieser Studien, obwohl klare Belege für die Wirksamkeit der Medikamente vorlägen. Sie appelliert, diese Studien fortzuführen, da man international führend im Verständnis und bei den Konzepten für deren Durchführung sei und deutsche Firmen als Partner zur Zulassung der Medikamente gewonnen werden könnten.

Daniel Vilser (Vizepräsident Ärzte- und Ärztinnenverband Long COVID)² betont, dass die Patienten wirksame Therapien brauchten. Grundlage hierfür sei eine saubere Definition des Krankheitsbildes zur guten Patientenselektion sowie Versorgungsstrukturen wie Spezialambulanzen. Diese Patienten seien aufwendig zu behandeln und benötigten viel Zeit und Unterstützung, weshalb sie derzeit nicht über die Regelversorgung abgebildet werden könnten. Beispielhaft nenne er PEDNET-LC (Pediatric Network for Care and Clinical Research), das Strukturen zum Aufbau, zur Etablierung und zur Sicherung und Beforschung von pädiatrischen Patienten ermögliche. Gleichzeitig könne die Abhängigkeit von limitierten Förderungen dazu führen, dass die mit großem Aufwand etablierten Strukturen, die die Grundlage für die Biomarkerforschung und Reaktion mit wirksamen Therapien bildeten, wieder verloren gingen, wenn nicht rechtzeitig eine Anschlussförderung komme.

Simon Schöning (Long COVID Deutschland)³ führt aus, unverändert bestünden Barrieren, die einer flächendeckenden medizinischen und sozialen Versorgung im Wege stünden. Hausarztpraxen seien in der Regel nicht für die ausführliche Diagnostik ausgestattet, und der Aufwand werde unzureichend über die EBM-Ziffern abgedeckt. Die allgemeine kassenärztliche Versorgung funktioniere oft nicht, da vielen Versorgenden das Wissen fehle und daher Off-Label-Medikamente nicht verschrieben würden. Ein möglicher Lösungsansatz sei die Etablierung von Kompetenzzentren oder Schwerpunktpraxen sowie strukturierter und standardisierter

Behandlungsprogramme. Besonders gravierend sei die Lage für Menschen mit schwerer Krankheit, die keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung hätten. Neupatienten müssten mit langen Wartezeiten rechnen. Die Versorgung mit Hilfsmitteln und die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit, Assistenzbedarf oder Schwerbehinderung sei oft nur durch Widerspruch oder Klage zu erreichen.

Reha-Maßnahmen könnten höchstens zu einem besseren Krankheitsmanagement verhelfen, heilten jedoch nicht die zugrunde liegenden Krankheitsmechanismen, weshalb die medikamentöse Therapie zum zentralen Baustein der Versorgung werden müsse. Die Umsetzung der Empfehlung der Expertengruppe Long-COVID-Off-Label-Use müsse flächendeckend erfolgen. Aus Sicht der Betroffenen sei die Medikamentenforschung der erfolgversprechendste Weg. Notwendig sei zudem die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Therapievorhaben, Förderrichtlinien für klinische Therapiestudien mit begleitender Biomarkerforschung sowie die langfristige und angemessene Förderung zentraler Therapieplattformen wie der NKSG und dem Netzwerk Universitätsmedizin. Zudem sollten Anreize für eine zeitnahe Beteiligung der pharmazeutischen Industrie an der Therapieforschung geschaffen werden, etwa durch einen Pharma-Roundtable. Angesichts der geschätzten Gesamtkosten beider Erkrankungen in Höhe von 63 Milliarden Euro im Jahr 2024 und bei Investitionen der Bundesregierung von ca. 15 Millionen Euro jährlich in die Forschung, plädiere er eindringlich für eine deutliche Aufstockung der Fördermittel für die Grundlagen- und Therapieforschung.

Abg. **Nora Seitz** (CDU/CSU) fragt Prof. Dr. Scheibenbogen, wie die Umsetzung von Forschungsergebnissen in der medizinischen Versorgung beschleunigt werden könne. Sie erkundigt sich, ob es angesichts der vielfältigen und unterschiedlichen Symptome sowie der Überschneidungen mit anderen Krankheiten mit den aktuell vorhandenen Diagnosekriterien überhaupt möglich sei, eine klare und verlässliche Diagnose zu stellen. Weiterhin fragt sie Herrn Vilser nach den momentan größten Herausforderungen in der Versorgung von Long-Covid-Patienten beziehungsweise ME/CFS-Erkrankten und welche Unterschiede es zwischen beiden Gruppen

² Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)28

³ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)39



Nur zur dienstlichen Verwendung

gebe.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité – Universitätsmedizin Berlin) antwortet, dass relativ klare, wenngleich aufwendige Kriterien zur Diagnosestellung vorhanden seien, welche Spezialambulanzen erforderten, da der Hausarzt die Diagnosestellung kaum leisten könne. Die diagnostische Schärfe sei relativ hoch, wobei eine diagnostische Unsicherheit bei einigen Patienten natürlich bleibe, was ebenso bei anderen Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose der Fall sei. Hinsichtlich der Medikamentenentwicklung seien in der NKSG wichtige Fortschritte erzielt worden. Medikamente könnten relativ zügig zur Zulassung gebracht werden, wenn die Zusammenarbeit mit der Industrie nun intensiviert werde. Diese zeige nach anfänglichem Desinteresse im Jahr 2022 jetzt zumindest ein Grundinteresse. Die Grundlagen seien geschaffen worden, wobei aufgrund von Untergruppen in den Krankheitsmechanismen für einzelne Subgruppen unterschiedliche Medikamente entwickelt werden müssten. Erste Partnerschaften wie etwa mit Sanofi und Neuraxpharm seien vorhanden, doch müssten dringend Phase-II-Studien durchgeführt werden, um den Antikörperansatz, bei dem man international führend sei, zur Zulassung zu bringen.

Daniel Vilser (Vizepräsident Ärzte- und Ärztinnenverband Long COVID) erläutert den Unterschied zwischen Long-Covid und ME/CFS dahingehend, dass Long-Covid durch den Trigger SARS-CoV-2 ausgelöst werde, während ME/CFS ein möglicher schwerer Verlauf von Long-Covid sei. Die größte Herausforderung in der Versorgung stelle die Aufwändigkeit der Patienten dar, da diese eine Vielzahl schwer zuzuordnender Symptome hätten und der Ausschluss anderer Erkrankungen sehr aufwändig sei. Dies gelinge dem Hausarzt aus Zeitmangel nicht. Deswegen seien Spezialambulanzen notwendig, deren flächendeckende Etablierung gerade erst im Aufbau sei, wobei der pädiatrische Bereich bereits etwas weiter sei.

Abg. **Nora Seitz** (CDU/CSU) fragt, wie die Einführung eines Disease-Management-Programms (DMP) für diese Erkrankungen bewertet werde, da DMPs strukturierte Behandlungswege schafften.

Daniel Vilser (Vizepräsident Ärzte- und Ärztinnenverband Long COVID) hält ein DMP für sehr gut und notwendig, da es eine solide Finanzierung ermögliche und helfe.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, welche Rolle die bei Corona freigesetzten Spike-Proteine bei den kleinsten Gefäßveränderungen bei Long-Covid spielten.

PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger (Universitätsklinikum Erlangen)⁴ führt aus, man gehe davon aus, dass die Durchblutungsveränderungen auf spezifische Antikörper zurückzuführen seien. Dies sei ein Immunphänomen, das durch virale Infektionen wie SARS-CoV-2, aber auch nach EBV-Infektionen (Epstein-Barr-Virus), ausgelöst werden könne. Der Virus selbst sei in diesem Fall nur der Anlass, nicht aber die Ursache. Die Ursache liege im Körper der Menschen, die eine fehlgerichtete Immunantwort hätten und falsche Eiweißstoffe, nämlich diese Autoantikörper, bildeten, welche dann den Zellstoffwechsel durcheinanderbrächten und zu Durchblutungsveränderungen führten.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt nach, ob die Spike-Proteine in diesem Zusammenhang gar keine Rolle spielten.

PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger (Universitätsklinikum Erlangen) antwortet, die Spike-Proteine seien der Anlass für eine fehlerhafte Reaktion des Immunsystems.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, wenn die Spike-Proteine der Anlass für eine fehlerhafte Reaktion des Immunsystems seien, ob es nicht kontraproduktiv sei, dass durch die Impfung die körpereigenen Zellen genau dazu angeregt würden, diese

⁴ Anlage: Ausschussdrucksache 21(14)29



Nur zur dienstlichen Verwendung

Spike-Proteine zu produzieren und in den Körper abzugeben.

PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger (Universitätsklinikum Erlangen) erklärt, Post-Covid und Post-Vac umfassten verschiedene Untergruppen. Es gebe Personen, bei denen die Impfung eindeutig schützend sei und das Risiko von Post-Covid mindere, aber auch Personen, die durch die Impfung Probleme, also Post-Vac entwickelten. Man dürfe nicht alle Patienten in einen Topf werfen, sondern müsse sich die einzelnen Patienten und deren Untergruppen genau anschauen, ob sie zu der Gruppe gehörten, wo die Impfung schützend sei oder zu der, wo es in Post-Vac ende.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) wendet ein, da die Differenzialdiagnostik schwierig sei, sei es schwierig festzulegen, welcher Gruppe die Patienten am Ende zuzuordnen seien.

PD Dr. med. Dr. rer. biol. hum. Bettina Hohberger (Universitätsklinikum Erlangen) bejaht, dass dies die Herausforderung sei. Dies sei genau einer der Ansätze der vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) unterstützten Projekte, Diagnostika für spezifische Untergruppen zu entwickeln. Diese stünden aktuell noch nicht in der Regelversorgung zur Verfügung, was aber das Ziel der laufenden Förderungen sei.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt Prof. Dr. Scheibenbogen, ob sie einen Ansatz zur Differenzialdiagnostik von ME/CFS, postviralen Erkrankungen und Impfschäden habe, also ob eine klare Differenzierung möglich sei.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité Berlin): führt aus, das Krankheitsbild ME/CFS könne unabhängig vom Auslöser diagnostiziert werden. In ihrer Ambulanz sehe man in der Tat Patienten mit dem Vollbild von ME/CFS, das von der Anamnese her möglicherweise durch die Impfung ausgelöst worden sei. Sie ergänzt, Impfstoffe stimulierten das Immunsystem, was zu Autoimmunreaktionen führen könne. Dies kenne man auch von anderen Impfstoffen. In der Medizin müsse immer das Risiko einer Therapie gegen den Nutzen abgewogen werden,

wobei das Risiko, eine schwere Folgeerkrankung durch die Impfung zu erleiden, um ein Vielfaches kleiner sei als durch eine Infektion. Die Infektion sei ein „Flächenbrand“ und führe zu einer langanhaltenden Stimulation des Immunsystems, während die Impfung ein „kleines Lagerfeuer“ sei. Sie verweist darauf, dass es bereits vor der Impfung viele ME/CFS-Erkrankte gegeben habe.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt nach, ob dann die erwähnten Mehrwerte der Impfung überhaupt nachgewiesen werden könnten, da keine Unterscheidung zwischen Impfschaden und Corona-Infektion möglich sei.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité Berlin) entgegnet, sie sehe es bei den allermeisten Patienten am zeitlichen Zusammenhang, da die meisten Erkrankten im zeitlichen Zusammenhang mit einer Infektion und nicht mit der Impfung stünden. Sie weist darauf hin, dass die Impfung vor schweren Verläufen und zumindest teilweise vor Long-Covid schütze, auch wenn eine Klärung im Einzelfall nicht möglich sei.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) bedankt sich bei allen Sachverständigen für die wichtige Arbeit in Forschung, Versorgung und Patientenvertretung. Gemeinsam habe man bereits viel erreicht. Sie fragt Herrn Vilser, wie Weiterbildungsangebote für Allgemeinmediziner und Pädiater gefördert werden könnten und welche Rolle das Primärärztsystem bei der Versorgung und Koordination der Behandlung spielen könnte.

Daniel Vilser (Vizepräsident Ärzte- und Ärztinnenverband Long COVID) bejaht die essenzielle Rolle des Primärärztsystems. Es sei sinnvoll, dass Patienten zuerst zum Hausarzt gingen, der die Erkrankung erkennen und den Patienten zu Spezialisten weiterleiten müsse. Dies funktioniere aber nur, wenn es auch Spezialisten gebe. Wenn die Erkrankung nicht erkannt werde, liege die Aufgabe der Politik darin, mittels einer Kampagne die Wahrnehmbarkeit der Erkrankung zu erhöhen. Diese sei derzeit schlecht. Die Pflicht der Ärzteschaft sei es, für Fortbildungsangebote zu sorgen. Er berichtet von jährlichen Kongressen des Ärzteverbands Long COVID und einer langsam beginnenden Etablierung



Nur zur dienstlichen Verwendung

von Fortbildungsangeboten bei Landesärztekammern und auf Fachkongressen wie der Jahrestagung der Kinderärzte, was zeige, dass die Erkrankung langsam Eingang in die großen Fachgremien finde.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) fragt Prof. Dr. Scheibenbogen nach dem Hintergrund der Nichtauszahlung der 8 Millionen Euro, die der Haushaltsausschuss 2024 für die Studie der NKGS zur Verfügung gestellt habe.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité Berlin): erklärt, die Mittel seien im Haushaltsausschuss 2024 für die NKSG im Einzelplan 30 eingestellt worden. Das Geld sei beim Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) beantragt worden. Es habe jedoch wiederholte Begutachtungen und Rückfragen gegeben, auf die man Gegendarstellungen habe schreiben müssen. Letztendlich sei die Bewilligung wegen eines Gutachters, der das Konzept und Studiendesign infrage gestellt habe, nicht erfolgt. Sie betont, man habe klare Wirksamkeitsdaten, Biomarker und Medikamente und habe bereits Heilversuche mit dem CD19-Antikörper durchführen können. Das Geld sei aber dennoch bislang nicht ausgezahlt worden. Dies sei bedauernswert, da eine Entscheidung von derartiger Tragweite nicht von einem einzelnen Gutachter, der manche Dinge offensichtlich nicht richtig einschätze, abhängig gemacht werden sollte.

Abg. **Matthias Mieves** (SPD) fragt Herrn Musch nach den Erfahrungsberichten zum Einsatz von Avataren im Lernalltag und wie sichergestellt werden könne, dass alle, die einen Avatar benötigten, diesen auch bekämen, unabhängig vom Wohnort.

Sebastian Musch (Deutsche Gesellschaft ME/CFS) antwortet, Avatare könnten ein sehr hilfreiches Mittel zur Förderung der schulischen Teilhabe bei Kindern sein, die zu schwer erkrankt oder bettlägerig seien, um zur Schule zu gehen. Es gebe jedoch praktische Herausforderungen, da die Technik laute Hintergrundgeräusche, wie bei Gruppenarbeiten, oft nicht herausfiltern könne. In solchen Fällen könne die Reizbelastung oder eine instabile Internetverbindung zu einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustands des Kindes führen, weshalb eine individuell angepasste Einzelbeschulung

insbesondere durch Lehrkräfte im Homeoffice besser wäre.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt Prof. Dr. Scheibenbogen, an welchen Stellen man schneller werden könne, ob es inzwischen passendere Reha-Angebote gebe, ob diese genutzt und verschrieben würden und welche politischen Maßnahmen zur Beförderung der richtigen Reha-Angebote ergriffen werden könnten. Weiterhin fragt sie zum Runden Tisch Long-COVID, ob dieser konstant und weiterhin arbeite und wie es um die Off-Label-Use-Medikamente stehe, die im Rahmen des Runden Tisches identifiziert worden seien.

Prof. Dr. Carmen Scheibenbogen (Charité Berlin) antwortet, dass man bei der Rehabilitation differenzieren müsse, da ein großer Teil der Long-Covid- und alle ME/CFS-Betroffenen nicht belastbar seien, sodass eine klassische Reha oftmals zur Verschlimmerung der Krankheit führe. Es sei ein ME/CFS-angepasstes Reha-Konzept entwickelt und umgesetzt worden, welches die Patienten als hilfreich für den Umgang mit der Erkrankung und die Symptombehandlung erlebt hätten, das jedoch die Erkrankung nicht wesentlich verbessert habe. Sie betont, dass für schwerer erkrankte Patienten die Reha-Pflicht aufgehoben werden müsse.

Zum Runden Tisch teilt sie mit, dass dieser für die Öffentlichkeitsarbeit sehr hilfreich gewesen sei und sie hoffe, ihn fortsetzen zu können. Sie arbeite in der Off-Label-Kommission. In Deutschland seien die regulatorischen Auflagen für die Off-Label-Anwendung von Medikamenten hoch. Die Kommission habe alle Evidenzen erarbeitet und fünf Medikamente identifiziert, für die die Hoffnung bestehe, dass der G-BA den Off-Label-Status erteile. Da der G-BA für die evidenzbasierte Prüfung zuständig sei, sei es noch ein sehr langer Weg.

Abg. **Linda Heitmann** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt Herrn Musch, ob er Erkenntnisse darüber habe, wie das Angebot an Fortbildungen deutschlandweit bei den Ärztekammern aussehe und wie die Teilnahmeraten unter der Ärzteschaft seien.

Sebastian Musch (Deutsche Gesellschaft ME/CFS): bestätigt, dass es Fortbildungsangebote gebe, die von den Landesärztekammern über verschiedene



Nur zur dienstlichen Verwendung

Organisationen durchgeführt würden. Er merkt an, dass das Wissen, insbesondere zu ME/CFS und Long-Covid, nicht im gesamten Bundesgebiet auf demselben Stand sei, weshalb es wichtig sei, dass die Vortragenden Expertise hätten und möglicherweise die Krankheitsbilder selbst beforschten. Er berichtet, dass die Deutsche Gesellschaft ME/CFS selbst Fortbildungen durchführe. Eine Fortbildung im letzten Jahr habe 730 Teilnehmer verzeichnet, was nur einen Bruchteil der Angemeldeten darstelle. Dies zeige, dass es schwierig sei, die Fortbildung in den individuellen Arbeitsalltag der Teilnehmenden, vornehmlich medizinische Fachangestellte, Psychotherapeuten oder Pfleger zu integrieren.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) fragt Simon Schöning nach dem Stand des versprochenen Aufbaus eines Netzwerks von Spezialambulanzen durch die Regierung und wie die Unterstützung der Bundesregierung tatsächlich aussehe.

Simon Schöning (Long COVID Deutschland) antwortet, die Einrichtung eines deutschlandweiten Netzwerks von Kompetenzzentren und Spezialambulanzen sei eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag der letzten Bundesregierung gewesen. Da die Gesundheitsversorgung Ländersache sei, habe die Bundesregierung nur begrenzte Möglichkeiten zur Einrichtung eines solchen Netzwerks. Er denkt, dass die vom BMG geförderten Versorgungsforschungsvorhaben, die in einigen Jahren evaluiert würden, Impulse und Standards setzen sowie zeigen könnten, wie Versorgungsforschung im Hochschulbereich funktioniere. Die bestehenden Kompetenzzentren, also die Post-Covid-Ambulanzen und die zwei bis drei ME/CFS-Ambulanzen hätten weiterhin Finanzierungsprobleme und es sei keine Langfristigkeit gegeben. Die Bundesregierung könne zumindest die Koordination der bestehenden Post-Covid-Ambulanzen in ihren Verantwortungsbereich übernehmen.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) fragt Herrn Schöning, welche Instanz die sozialrechtlich verbrieftete Leistung verweigere, und welche Empfehlungen er der Politik gebe, da viele Betroffene den Versorgungsanspruch nur durch Widersprüche gegen Ablehnungen oder gerichtliche Schritte durchsetzen könnten.

Simon Schöning (Long COVID Deutschland) antwortet, die Verweigerung liege im Unwissen aufseiten der Gutachtenden. Diese wüssten schlicht nicht, worum es bei ME/CFS gehe, wie schwer erkrankt die Betroffenen seien, und stellten dementsprechend den Anspruch auf Leistung infrage. Betroffene sähen sich als Folge gezwungen, Klagen einzurechnen. Das sei ein schwieriger und anstrengender Prozess, den viele Betroffene nicht durchstehen könnten. Als möglicher Lösungsansatz sei das Thema Aufklärung in allen Bereichen, auch im Bereich der Sozialmedizin und der sozialmedizinischen Begutachtung, notwendig. Es müsse eine flächendeckende, breite Aufklärung aller mit der Begutachtung betrauten Stellen zu dem Krankheitsbild, der Diagnose und den Symptomkomplexen sowie der damit verbundenen Einschränkung des Lebens der Betroffenen erfolgen.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) fragt, ob er im Hinblick auf die Deutungsfrage der Behandlung und der Ursache von ME/CFS und Long-Covid angesichts der immer zugespitzten politischen Situation eine Art Kulturkampf sehe, und welche Beharrungskräfte dahinter stünden.

Simon Schöning (Long COVID Deutschland) antwortet, er könne hierüber nur spekulieren. Die Hoffnung der Betroffenen sei, dass Long-Covid und ME/CFS wie alle anderen Erkrankungen auch angesehen, anerkannt, behandelt und erforscht würden. Es bestehe kein Interesse der Betroffenen an einem sogenannten Kulturkampf, sondern sie wünschten sich, dass sich die Bundesregierung dem Thema angemessen und langfristig annehme, entschieden in die Forschung investiere und Therapien auf den Weg bringe.

Tagesordnungspunkt 9

Fachgespräch zur HNO-Versorgung von Kindern und Jugendlichen

Selbstbefassung S-21(14)25

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) führt aus, dass die flächendeckende Zusammenarbeit zwischen Kinder- und HNO-Ärzten im Land gut funktioniere. Problematisch sei jedoch die operative



Nur zur dienstlichen Verwendung

Versorgung von Kindern, welche oft vergrößerte Rachen- oder Gaumenmandeln sowie chronische Paukenergüsse hätten. Obwohl die dazugehörigen Eingriffe operativ nicht hochkompliziert seien, seien sie mit Blutungsgefahren im Bereich der oberen Atemwege verbunden und erforderten eine Narkotisierung des Kindes, weshalb der Operateur bis zur sicheren Verlegung in den Aufwachraum unmittelbar beim Kind bleiben müsse. Folglich gebe es Wartezeiten für diese Operationen, was bei den unbehandelten Kindern zu Nasen- und Atmungsbehinderungen, Hörminderungen, Mittelohrentzündungen und Sprachentwicklungsverzögerungen führe. Strukturell ursächlich sei die sinkende Anzahl von Operateuren, die in den letzten Jahren um etwa 30 Prozent zurückgegangen sei, sowie Klinikschließungen und Kündigungen von Verträgen durch Klinikbetreiber, da andere Operationen wirtschaftlicher seien. Eine Lösungsmöglichkeit sei die Umstellung des Vergütungssystems. Sinnvoll sei zum Beispiel einen bestimmten Betrag, etwa 10 bis 20 Prozent, von den DRGs (diagnosebezogene Fallgruppen) abzuziehen, welcher die stationären Kosten enthalte und von beiden Sektoren, den ambulanten und stationären Trägern erbracht werden könne, um so eine qualitätsgesicherte Versorgung der Kinder nach dem Stand der Technik zu ermöglichen.

Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie e. V.) erklärt, dass ein nicht hörendes Kind zudem oft eine Art obstruktives Schlafapnoesyndrom entwickle. Dies führe insgesamt zu neurokognitiven und metakognitiven Defekten. Die fehlende Informationsverarbeitung beeinträchtige die Schulung der Ohr-Hirn-Achse, was für die Umwandlung des Gehörten in eine verwertbare Nachricht essenziell sei. Es sei bekannt, dass bei älteren Menschen Hörminderung leicht zu Demenz führe; dasselbe gelte für Kinder während ihrer Sprachentwicklung, wo das Zeitfenster für die Informationsaufnahme und -verarbeitung offen sei. Zudem könne sich ein Kind, das nicht höre und Informationen nicht verarbeite, nicht strukturieren. Auch emotionale Verarbeitungen fänden nicht statt, was zu aggressivem Verhalten führen könne. Man beobachte deutlich mehr ADHS-Kinder, die nicht gut hörten. Aufgrund der bestehenden Versorgungslücke steige die Zahl der Kinder, die nachträglich logopädische

Therapien und Hörgeräte benötigten, obwohl eine 20-minütige Operation das Problem beheben könnte. Sie weise darauf hin, dass bereits 2016 jedes zehnte eingeschulte Kind als sprachentwicklungsverzögert diagnostiziert worden sei. Sie arbeite in München, wo sozialpädiatrische Zentren Wartefristen von zwölf Monaten für auffällige Kinder hätten. Sei ein Kind bei der Vorschuluntersuchung mit vier Jahren sprachentwicklungsverzögert, blieben nur noch zwei Jahre, das Defizit aufzuholen. Das Zeitfenster der Chance, in dem Hören wieder regeneriert werden könne und das Kind Anschluss an die Verarbeitungsstrategien finde, reiche insgesamt nur bis zum achten Lebensjahr.

Christian Hartnik (Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffenstein) führt aus, dass sich die HNO-ärztliche Versorgung für behandlungsbedürftige Kinder in den letzten fünf bis sieben Jahren in besorgniserregendem Maße verändert habe. Die Zahl der ambulant erbrachten Adenotomien, Paukendrainage-Einlagen und Tonsillotomien sei deutlich zurückgegangen. Der Streik der HNO-Ärzte von Dezember 2022 bis einschließlich Sommer 2024 habe die Situation stark verschärft. Niedergelassene HNO-Ärzte seien in seiner Region größtenteils nur noch konservativ tätig, da sie ihre ambulante Operationszulassung wegen der Rahmenbedingungen zurückgegeben hätten. Kliniken seien vielfach nicht kooperativ bei der Vergabe von OP-Kapazitäten an HNO-Ärzte, da es nicht lukrativ sei. HNO-Abteilungen hätten, auch an Unikliniken, aufgrund der Rahmenbedingungen und des Streiks die OP-Kapazitäten ebenfalls deutlich eingeschränkt. Die Kapazität der Adenotomien an der Uniklinik Erlangen seien im Jahr 2024 auf ein Drittel der ursprünglichen Kapazität gesunken. Dementsprechend seien die Wartezeiten für einen OP-Termin von mehreren Monaten auf aktuell ein bis zwei Jahre gestiegen, was bedeute, dass Kinder, die behandlungsbedürftig seien, mindestens ein Jahr warten müssten. Die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder sei in dieser Zeit explodiert und es habe sich eine große Welle an Patienten aufgetürmt. Die Auswirkungen auf die Kinder, ihre Familien und die gesamte Gesellschaft seien enorm, auch wegen der Folgekosten durch Fehlzeiten. Die Belastung für ambulant tätige Kinderärzte sei aufgrund der unzureichend kausal behandelten Kinder unerträglich, da konservative Behandlungsmöglichkeiten fehlten und die Evidenz von kortisonhaltigen



Nur zur dienstlichen Verwendung

Nasensprays fraglich sei. Täglich habe man mit den Folgen der nicht operierten Kinder zu tun, welche unter Mittelohrbelüftungsstörungen, Paukenergüssen, wiederkehrenden Mittelohrentzündungen und damit verbundenen Hörstörungen litten. Auch die tieferen Atemwege seien häufig beteiligt, was chronische Bronchitiden, bronchiale Hyperreagibilität und intrinsisches Asthma nach sich ziehe. Neben Kinderärzten seien Allgemeinärzte, HNO-Ärzte, Lungenfachärzte sowie Sozialpädiatrische Zentren, Logopäden und Fördereinrichtungen gefragt, um sich um diese insuffizient behandelten Kinder zu kümmern.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) erwähnt eine Phase höherer medialer Aufmerksamkeit, die durch den Boykottaufruf des Berufsverbandes ausgelöst worden sei, dessen Anlass die Entscheidung des Bewertungsausschusses zur Neukalkulation ambulanter Operationen gewesen sei. Bei diesem Beschluss seien leichte Operationen leicht ab- und komplexere Operationen leicht aufgewertet worden, was für die HNO-Ärzte in der Summe ein Honorarplus von 2,3 Prozent bedeutet habe. Der Beschluss werde gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) weiterhin für sachgerecht gehalten. Er führt aus, dass immer wieder von Fällen berichtet werde, in denen Kindern trotz objektiver Dringlichkeit keine oder nur sehr späte OP-Termine angeboten würden. Es sei aber fraglich, ob diese Berichte auf individuelle Ursachen oder ein systemisches Problem zurückzuführen seien. Ein Blick in die Abrechnungszahlen des wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen, die ein Drittel der Versicherten abdeckten, zeige, dass sowohl bei Paukenröhrchen-OPs als auch bei Mandeloperationen nicht nur das Vor-Corona-Niveau erreicht, sondern teilweise deutlich übertroffen worden sei. Von einem Rückgang oder einer Stagnation der Operationen sei in den Abrechnungsdaten nichts zu sehen, bei Mandel-OPs sei sogar eine Verdoppelung gegenüber 2019 zu verzeichnen, wenn man ambulante Operationen im Krankenhaus und stationäre Fälle bis zu drei Tage zusammennehme. Bei den Paukenröhrchen-OPs sei das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht worden. Diese Zahlen bezögen sich zudem auf eine schrumpfende Alterskohorte aufgrund sinkender Geburtenzahlen. Er deutet dies dahingehend, dass es offenbar keinen flächendeckenden Boykott gegeben haben könne und auch keine generelle Unterfinanzierung des ambulanten

Operierens vorliege. Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigten bei operierenden HNO-Ärzten einen um 20 Prozent höheren Reinertrag als bei konservativen HNO-Ärzten. Eine Bereinigung um PKV-Einnahmen ändere daran nichts.

Florian Schönberg (Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD)) führt dagegen aus, die aktuelle Entwicklung in der ambulanten HNO-Versorgung im Kindesalter bereite große Sorgen. Es sei nicht akzeptabel, dass Kinder mit Hör- und Atemproblemen mehrere Monate, teilweise bis zu einem Jahr auf notwendige Eingriffe wie Paukenröhrchen- oder Mandeloperationen warten müssten. Hier sei die Versorgung gefährdet. Es handele sich nicht um Randfälle, sondern um häufige, medizinisch notwendige Eingriffe, die entscheidend seien, um Sprach-, Hör- und Entwicklungsstörungen zu vermeiden. Als Auslöser werde die Umverteilung der ärztlichen Vergütung seit Ende 2022 genannt, bei der kleinere Eingriffe etwas niedriger und aufwendigere höher bewertet worden seien. Die Reaktion auf diese Entscheidung der Selbstverwaltung, etwa mit Terminverweigerungen oder Boykottaufrufen, sei nicht verhältnismäßig und nicht verantwortungsvoll, denn die Kinder seien die Leidtragenden. Sie müssten frühzeitig behandelt werden. Die Versorgung dürfe nicht ausgesetzt werden, weil Verhandlungen stockten oder Ergebnisse nicht gefielen. Wer ambulant versorge, übernehme einen klaren Versorgungsauftrag, sowohl rechtlich als auch ethisch. Ärzte genossen hohes Ansehen und großes Vertrauen, welches beschädigt werde, wenn die Versorgung von Kindern zur Verhandlungsmasse gemacht werde. Eine medizinische Versorgung, die sich an wirtschaftlichen Minusrechnungen orientiere, sei auf Dauer nicht tragfähig, doch auch die Mittel der GKV seien begrenzt.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) fragt, wie sich die hohen Rückgangszahlen angesichts der Aussage der GKV erklären ließen, dass statistisch keine Versorgungslücke bestehe.

Christian Hartnik (Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffenstein) erwidert, es müsse zwischen den Zahlen differenziert werden, da Eingriffe wie die Mandelkappung (Tonsillotomie) erst später als GKV-Leistung anerkannt



Nur zur dienstlichen Verwendung

worden seien und die heutigen Zahlen mit jenen von vor 2019 daher nicht direkt vergleichbar seien. Er führt aus, die vorhandenen Wartezeiten seien bereits Ausdruck eines Mangelsystems.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) fragt, ob die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte durch den Boykott maßgeblich zur Verschärfung der Lage beigetragen hätten.

Christian Hartnik (Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffenstein) verneint dies und erklärt, die Probleme wie Kündigungen von Verträgen durch Kliniken und die Schwierigkeit, Termine zu finden, seien schon vor dem Boykottaufruf aufgetreten. Die Honorarreform habe zu einer weiteren Absenkung der Vergütung für kleinere Eingriffe geführt, was als falsche Richtung bewertet worden sei. Da Gespräche mit Politik und Krankenkassen zuvor ergebnislos geblieben seien, habe man den Boykott als einzige Methode zur Erzeugung von Öffentlichkeit und einer breiten Diskussion in dieser kritischen Situation angesehen.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) fragt, ob der Boykott nun gewirkt habe und sich die Versorgung in der Realität verbessert habe. Des Weiteren erkundige sie sich nach den realen Wartezeiten und der Verantwortung der Politik in dieser Frage.

Christian Hartnik (Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffenstein) antwortet, die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder habe sich durch diesen Boykott enorm gesteigert. Die aktuellen Wartezeiten von ein bis zwei Jahren in Bamberg und Erlangen zeigten keine Verbesserung der Versorgungslage, sondern machten es erforderlich, die sich aufgestaute Welle abzubauen. Dazu müssten die OP-Kapazitäten erhöht werden, doch das System sei nicht lukrativ. Bei einer Vergütung von 107 Euro pro Adenotomie fehle der Anreiz für einen niedergelassenen HNO-Arzt, dies auf Dauer ohne Defizite durchzuführen. Er schildert, dass er als Kinderarzt einzelne dringend behandlungsbedürftige Kinder durch persönliche, wiederholte Anrufe bei HNO-Ärzten zu Operationen „zutragen“ müsse. Dieses Engagement liege im Ermessen des einzelnen Kinder- oder Allgemeinarztes. Ein Kind mit sieben durchbrochenen Mittelohrentzündungen habe beispielsweise erst nach drei Monaten

Wartezeit einen OP-Termin erhalten. Im Einzelfall sei es Sache der Eltern, die Behandlung zu initiieren, wobei manche Eltern bereit seien, privat abzurechnen, was einzelne Kollegen ausnutzten.

Abg. **Emmi Zeulner** (CDU/CSU) bittet den GKV-Spitzenverband in späteren Antworten, Ansatzpunkte für Verhandlungen zu benennen, da die aktuelle Situation keinesfalls tragfähig sei.

Abg. **Claudia Weiss** (AfD) fragt Prof. Dr. Löhler nach konkreten Maßnahmen zur Verhinderung der Schließung von HNO-Belegabteilungen und zur Sicherstellung der Kinderversorgung. Zudem fragt sie nach dem Stand der Gespräche, die nach dem Boykott geführt worden seien.

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) stellt klar, dass ein niedergelassener HNO-Arzt nicht automatisch einen OP-Auftrag habe. Die HNO-Grundversorgung müsse angeboten werden, unabhängig von der auskömmlichen Finanzierung, aber für Operationen benötige der Arzt eine Genehmigung und müsse dafür entsprechende Voraussetzungen mitbringen sowie einen Partner oder eine Klinik finden. Die Operationskapazität könne ihm von Kliniken verweigert oder der Vertrag gekündigt werden. Er kenne viele Kollegen, die diese Eingriffe letztlich unentgeltlich durchführten, denen jedoch die OP-Kapazität von den Kliniken gestrichen werde. Bezüglich des Honorarplus, welches eine summarische Betrachtung darstelle, erläutert er, dass die meisten ambulant operierenden Kollegen sich auf die sogenannten Kindereingriffe fokussierten, da Nasennebenhöhlen- oder Ohroperationen eher selten seien und eine hohe Spezialisierung erforderten. Wenn diese geringergradigen Eingriffe, die abgewertet worden seien, eine weitere Abwertung erführen und das das einzige operative Segment im Spektrum sei, entstehe eine Schieflage. Dies führe entweder zur Aufgabe der Zulassung oder insbesondere bei jungen Kollegen zur Ablehnung der Niederlassung.

Er führt aus, dass die Möglichkeit der Hybrid-DRGs das Problem der Kinder nicht erfasse. Kinder würden bereits ambulant operiert und gehörten zu ihren Eltern und nicht in die Klinik, wodurch die Finanzierung über dieses System nicht vernünftig zu



Nur zur dienstlichen Verwendung

gestalten sei. Im Erweiterten Bewertungsausschuss der Selbstverwaltung fielen die Kinder ebenfalls durch das Raster. Dieses System funktioniere für Kinder nicht. Angesichts der Wartezeiten schlägt er vor, die Vergütung auf das DRG-System zu heben, abzüglich der stationären Behandlungskosten. Dadurch stünde ein Betrag zur Verfügung, der klinische Institutionen wie auch niedergelassene Ärzte wirtschaftlich dazu befähige, diesen Eingriff vernünftig abzubilden.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt, ob es richtig sei, dass eine Adenotomie mit 107 Euro erstattet werde, während die eigentlichen Kosten bei 250 bis 300 Euro lägen.

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) antwortet, dass die kalkulatorische Betrachtung schwierig sei, da Kosten wie Raummiete für den OP, Sterilisation des Instrumentariums, Personal sowie die ärztliche Leistung selbst, die Rufbereitschaft und Nachsorge regional sehr unterschiedlich seien. Er wolle sich nicht auf so genaue Zahlen festlegen lassen, halte aber den Grundvorschlag, von der DRG auszugehen, für pragmatisch. Mit 107 Euro funktioniere es jedenfalls nicht, sonst gäbe es keine Wartelisten.

Abg. **Kay-Uwe Ziegler** (AfD) fragt den GKV-Spitzenverband, ob es Ansätze zur Veränderung gebe, wenn bekannt sei, dass die OP mit 107 Euro unterfinanziert seien, und ob das Problem nun zulasten der kleinen Patienten bestehen bleibe.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) entgegnet, die Vergütung liege nicht mehr bei 107 Euro, sondern bei 115 Euro zuzüglich eines Hygieneschlags, womit von einem etwa 20 Prozent höheren Betrag gesprochen werde. Zur Behauptung, eine OP koste 200 Euro, während nur 130 Euro gezahlt würden, führt er an, diese sei mit den bereits erwähnten Zahlen nicht in Einklang zu bringen. Er wiederholt, dass operierende HNO-Ärzte einen deutlich höheren Reinertrag hätten als konservativ tätige Ärzte, weshalb die Plausibilisierung der Behauptung nicht standhalte.

Abg. **Dr. Lina Seitzl** (SPD) betont, dass die Problematik eine Frage der Selbstverwaltung sei. Sie fragt den GKV-Spitzenverband, ob dieser Handlungsbedarf im Hinblick auf nachgelagerte Vergütungsverhandlungen sehe und ob er die Bereitschaft der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) zur Mitwirkung annehme.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) antwortet, er könne nicht für die KBV sprechen, nehme jedoch an, dass diese ein Gespräch über höhere Vergütungen nicht ablehnen würde. Er beschreibt die aktuelle Lage so, dass aufgrund steigender Fallzahlen trotz der bestehenden Vergütungsregelungen und unter Berücksichtigung von ambulantisierten, früher stationären Leistungen wie der Tonsillotomie, dringende Fälle bis zu einem Jahr warten müssten. Ihn und andere im GKV-Spitzenverband beschäftige die Frage, nach welchen Kriterien die Termine vergeben würden. Normalerweise sei eine Terminvergabe nach medizinischer Dringlichkeit zu erwarten, weshalb es unplausibel erscheine, dass ein Arzt oder ein Krankenhaus ein Jahr im Voraus nur schwerere Fälle habe als der gerade akut vorliegende Fall. Er fragt, ob es abwegig sei, zu verlangen, dass die Terminvergabe nicht nach Kriterien wie „First come, first serve“ oder dem Versicherungstatus erfolge, sondern die Dringlichkeit in die Terminvergabe einbezogen werde. Solchen Patienten sollten dann frühere Termine gewährt werden, während weniger dringende Patienten verschoben würden. Dieses Vorgehen werde zwar wahrscheinlich in vielen Arztpraxen praktiziert, sei aber womöglich nicht immer die Regel.

Abg. **Serdar Yüksel** (SPD) möchte wissen, welche Ideen und Vorschläge die GKV habe, um den „Aderlass“ in der ambulanten Versorgung zu verhindern, insbesondere in Bezug auf zukunftsichere Vergütungs- und Strukturreformen.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) erklärt, der Kapazitätsabbau im stationären Bereich finde unter DRG-Bedingungen statt. Er könne nicht beurteilen, warum Krankenhäuser Abteilungen schliessen, da dies eine individuelle unternehmerische Entscheidung sei. Er bekräftigt, dass die Leistung zu den genannten Preisen ambulant erbracht werden könne und die Finanzierung der Leistung



Nur zur dienstlichen Verwendung

auskömmlich sei.

Abg. **Serdar Yüksel** (SPD) fragt Herrn Hartnik, was geschehen müsse, um den Zugang zu notwendigen HNO-Eingriffen zeitnah und unabhängig von Wohnort oder Einkommen zu gewährleisten, und welche Strukturveränderungen er empfehle.

Christian Hartnik (Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Staffenstein) führt aus, dass aus Sicht eines Praktikers die Zahl der operationsfähigen Kinder die Kapazitäten der Kliniken deutlich übersteige. Er bestätigt, dass eine Triage, also eine Auswahl der dringend behandlungsbedürftigen Patienten, vorgenommen werde und diese Kinder vorgezogen würden, sowohl von Kinder- als auch von HNO-Ärzten. Allerdings sei dies nicht ausreichend, um die aufgebaute Welle von Patienten abzuarbeiten. Zur Bewältigung der Situation müssten die Operationskapazitäten gesteigert werden.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) führt aus, dass ihn die aktuelle Situation als Kinderarzt sehr besorge und fragt zur rechtlichen Einordnung, wer die Aufgabe habe, die Sicherstellung der Versorgung aller bedürftigen Kinder zu gewährleisten.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) antwortet, dass der Sicherstellungsauftrag für die vertragsärztliche Versorgung bei den Kassenärztlichen Vereinigungen liege.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt Prof. Dr. Wollenberg, wie die Diskrepanz zwischen steigenden Patientenzahlen laut Krankenkassen und der schlechten Versorgungslage zu erklären sei.

Prof. Dr. med. Barbara Wollenberg (Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie e. V.) antwortet, dass diese Zahlen sehr erstaunten, da die tägliche Wahrnehmung in keiner Weise damit übereinstimme. Sie vermute, die Zahlen basierten auf einem nicht repräsentativen Kollektiv und entsprächen keiner

flächendeckenden Versorgung, da einige Niedergelassene vielleicht spezielle IGeL-Leistungen anböten.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt, wie angesichts des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigungen und der gestiegenen Vergütung die massiv artikulierte Unzufriedenheit und die Protestaktion der HNO-Ärzte zu erklären seien, welche eventuell eine zeitkritische Versorgung der Kinder gefährdeten.

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) führt aus, dass der Grundauftrag die Kassenärztlichen Vereinigungen verpflichte, eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Das bedeute, dass in seiner Praxis zwar Kassenleistungen wie Hör- und Gleichgewichtstests angeboten werden müssten, für Operationen jedoch eine extra Zulassung erforderlich sei, die unabhängig vom Sicherstellungsauftrag genehmigt werden müsse. Er weise darauf hin, dass er ohne verfügbare Klinik nicht mehr operieren könne, weshalb die operative Tätigkeit eingestellt werden müsse, trotz des Sicherstellungsauftrags.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt den GKV-Spitzenverband, wie er sich zu dieser Aussage verhalte.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) antwortet, dass das ambulante Operieren natürlich Teil der Versorgung sei, wozu die Kassenärztlichen Vereinigungen den Sicherstellungsauftrag hätten. Die vom Berufsverband angesprochene Abrechnungsgenehmigung entspreche einer Genehmigung gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung. Da die Qualitätssicherung ebenfalls Teil der Sicherstellung sei und von den Kassenärztlichen Vereinigungen nachgehalten werden müsse, halte er es fachlich für nicht richtig, wenn für Teile dieses Regelungskomplexes der Sicherstellungsauftrag gelten solle, für andere jedoch nicht.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt Herrn Feldmann, wie er den Dissens innerhalb der Kassenärztlichen Vereinigungen wahrnehme. Er wolle wissen, wie es dazu komme, dass



Nur zur dienstlichen Verwendung

der Versorgungsauftrag bei den Kassenärztlichen Vereinigungen liege, aber die HNO-Ärzte die Nichterfüllbarkeit beklagten.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) antwortet, dass er nicht für die KV-Vorsitzenden sprechen wolle und den Grund für diesen Dissens nicht nennen könne.

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) ergänzt, dass er zwar auch nicht für die Kassenärztlichen Vereinigungen sprechen könne, aber für seine Kollegen ausführe. Er erklärt, dass vor der Antragstellung zum Operieren eine wirtschaftliche Kalkulation vorgenommen werde. Er betone, dass insbesondere junge, neu niedergelassene Kollegen, die Kredite aufgenommen hätten, den Antrag nicht stellen würden, wenn der mögliche Erlös und die damit verbundenen Risiken die wirtschaftliche Führung der Praxis nicht gewährleisteten. Wenn der Antrag nicht gestellt werde, könne auch keine Genehmigung erfolgen, weshalb dann nicht operiert werde.

Abg. **Johannes Wagner** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) bittet Herrn Schönberg um dessen Einschätzung der gesamten Situation. Er weist auf die vielen Zuschriften von Eltern seit 2023 hin, in denen lange Wartezeiten beklagt würden, und frage, ob die Protestaktion der HNO-Ärzte aus dieser Perspektive als verhältnismäßig beurteilt werde.

Florian Schönberg (Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD)) führt aus, dass die Patientinnen und Patienten die negativen Folgen der verzögerten Behandlung unmittelbar zu spüren bekämen. Es sei erschreckend, dass sich über zwei Jahre die Behandlungen aufgestaut hätten, was nicht hinnehmbar sei. Er sehe die versorgenden Ärzte in der Pflicht, diesen Anstau nunmehr abzuarbeiten und aufzuholen.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) führt aus, dass sie als Fachkinderkrankenschwester und Mutter die negativen Auswirkungen aus der Praxis bestätigen könne. Sie fragt Herrn Schönberg, wo genau er Ross und Reiter in dem Konflikt sehe, da die

Versicherten einen Versorgungsanspruch, die Kassenärztlichen Vereinigungen einen Sicherstellungsauftrag und die Ärztinnen und Ärzte vertragsärztliche Pflichten hätten.

Florian Schönberg (Sozialverband Deutschland e. V. (SoVD)) antwortet, dass er alle Partner der Selbstverwaltung in der Pflicht und Verantwortung sehe, Lösungen zu finden. Er halte die Protestaktion für unverhältnismäßig und verantwortungslos, weil sie dazu geführt habe, dass notwendige Eingriffe aufgeschoben worden seien.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke) fragt Herrn Feldmann und Herrn Löhler, wie sie das Spannungsfeld zwischen dem staatlichen Sicherstellungsauftrag und der ärztlichen Freiheit in diesem besonderen Fall sähen. Sie fragt, ob sich die individuelle Versorgungspflicht von Ärztinnen und Ärzten, die an der kassenärztlichen Versorgung teilnähmen, auf den gesamten Leistungskatalog oder nur auf lukrativ eingeschätzte Behandlungen beziehe.

Stephan Feldmann (GKV-Spitzenverband) antwortet, es gebe eine Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, dass ein Arzt eine Leistung nicht ablehnen dürfe, weil sie ihm nicht lukrativ erscheine. Er ergänzt, dass den HNO-Ärzten, insbesondere den operierenden, in der Gesamtschau aller Leistungen ein sehr auskömmliches Einkommen sichergestellt sei. Er sehe das Spannungsfeld zwischen Sicherstellungsauftrag und Freiberuflichkeit, in dem die Ärzte lebten. Er weise darauf hin, dass Berufsfreiheit mit Verantwortung einhergehe, welche untrennbar verbunden seien, und sich in erster Linie an die Versorgten richte. Die derzeitige Situation führe zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen, wie beispielsweise beim Hautkrebs-Screening beobachtet worden sei, als Ärzte ihre Zulassung zurückgegeben hätten, um Leistungen „zu IGeln“.

Prof. Dr. med. habil. Jan Löhler (Deutscher Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.) stimmt Herrn Feldmann zu, dass nicht die Lukrativität bestimmter Leistungen die Richtschnur für die Erbringung sein dürfe und eine Mischkalkulation gelte. Er betone aber, dass sich dies nur auf die Grundversorgung eines konservativ tätigen HNO-



Nur zur dienstlichen Verwendung

Arztes beziehe. Als Beispiel nennt er die hochdefizitäre, aber notwendige Audiometrie. Für Operationen müssten eigene Voraussetzungen mitgebracht werden. Die abgewerteten Kinderoperationen könnten nicht mit höherwertigen Eingriffen querfinanziert werden. Wenn der Fokus nur auf Kinderoperationen liege, sei dies ein Zuschussgeschäft, weshalb der entsprechende Antrag auf Zulassung nicht gestellt werde. Er sehe die Gesetzgebung als verantwortlich für die Schließung von Kliniken, wobei er das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) in Nordrhein-Westfalen nenne, welches zu 32 HNO-Kliniksicherungen und damit zu 4 000 wegfallenden Eingriffen geführt habe. Er erklärt, dass das Problem in der Selbstverwaltung darin liege, dass der Fokus auf die Kinder fehle, da auf die Gesamtversorgung der Bevölkerung geachtet werde. Kinder seien hochvulnerabel, kompliziert, bräuchten viel mehr Betreuung und hätten ein erhebliches lebensbedrohliches Risiko im Hintergrund, das ständig abgefedert werden müsse. Dieser Aufwand werde im Einheitlichen Bewertungsmaßstab nicht abgebildet.

Tagesordnungspunkt 10

a) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neuenpsychoaktive-Stoffe-Gesetzes

BT-Drucksache 21/1504

b) Unterrichtung durch die Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Neuenpsychoaktive-Stoffe-Gesetzes

- 21/1504 -

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung

BT-Drucksache 21/1927

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1504, 21/1927 ein.

Abg. Ates Gürpınar (Die Linke) fragt, ob es Überlegungen gegeben habe, die Themen Lachgas und K.o.-Tropfen in anderen Bereichen als dem Neuenpsychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) zu regeln, da dies kritisch gesehen werde. Er weise darauf hin, dass Handlungsbedarf gesehen werde und nenne

alternative Regelungsbereiche wie Verkaufseinschränkungen, die Chemikalien-Verbotsverordnung oder das Betäubungsmittelgesetz (BtMG).

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, man habe den sachgerechten Zusammenhang gesucht und die Einordnung in diese Stoffe als am meisten übereinstimmend angenommen.

Abg. Linda Heitmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt nach, ob geplant sei, die Auswirkungen des Gesetzes nach Inkrafttreten zu beforschen, um festzustellen, ob eine Nachsteuerung nötig werde, falls das Instrument nicht ausreichend sei.

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bestätigt, dass eine ununterbrochene Evaluierung von Gesetzesvorschriften, insbesondere von Verbotsnormen zum Schutz der Bevölkerung, vorgenommen werden müsse. Er weise aber auf die enorme Herausforderung hin, einen Stoff zu regulieren, der in anderer Darreichungsform oder in größeren Gebinden benötigt werde, weshalb kein Totalverbot ausgesprochen werden könne. Er nehme an, dass allein durch das Besitz-, Vertriebs- und Versandhandelsverbot die Verkehrsfähigkeit massiv reduziert werde, was beobachtet werden müsse. Die Durchführung der Vorschriften erfordere, vor allem wegen der in der Öffentlichkeit wahrnehmbaren Kartuschen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Es werde über weitere Maßnahmen nachgedacht werden müssen, wobei die Konkurrenz zur notwendigen Verwendung in anderen Formen faktische Begrenzungen setze.

Tagesordnungspunkt 11

Nachbericht zur Sitzung des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz (EPSCO) (Formation Gesundheit) am 20. Juni 2025 in Luxemburg

Selbstbefassung S-21(14)12

gemeinsam mit



Nur zur dienstlichen Verwendung

Tagesordnungspunkt 12

Nachbericht des Bundesministeriums für Gesundheit zum Informellen Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und EU-Gesundheitsminister am 15. und 16. September 2025 in Kopenhagen, Dänemark

Selbstbefassung S-21(14)24

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass die Diskussion über den Critical Medicine Act im Vordergrund gestanden habe, wobei es um die europaweite Koordinierung der Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln sowie um die Entwicklung und um Vorschläge für Abhilfemaßnahmen gehe. Die Koordination sei angesichts divergierender Interessen eine große Herausforderung. Er merkt an, dass das Juni-Treffen die Premiere von Bundesministerin Warken zum Kennenlernen der europäischen Kollegen in Luxemburg gewesen sei, und betont, dass die Bundesregierung der europäischen Ebene große Aufmerksamkeit schenke, da der Austausch für die Verfolgung der deutschen Interessen sehr wichtig sei. Ein weiteres Thema im Juni seien Präventionsmaßnahmen gewesen, die sich auf die Verringerung von Tabak- und Alkoholkonsum sowie auf den Schutz der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im digitalen Zeitalter bezogen hätten. Dies stelle eine herausfordernde Konkurrenzsituation zwischen der Nutzung digitaler Medien als Therapie und deren Sucht- oder Beeinträchtigungspotenzial dar. Sowohl im Juni als auch im September sei das Pharma-Paket erörtert worden, wobei es um die Anregung von Produktionskapazitäten für innovative Arzneimittel und insbesondere für Antibiotika gegangen sei. Hiermit korrespondiere die Problematik der antimikrobiellen Resistenzen. Wesentlicher Inhaltspunkt sei der unter polnischem Ratsvorsitz entwickelte Gedanken, zur Sicherstellung der Versorgung eine kollektive Auftragsvergabe sowie eine europäübergreifende Bewirtschaftung von Bevorratungen in Erwägung zu ziehen, gegebenenfalls unter Einsatz europäischer Finanzmittel. Die deutsche Seite habe sich diesem Vorgehen gegenüber, mit Ausnahme absoluter Notfallsituationen, sehr kritisch gezeigt. Man sei nicht der Meinung, dass die unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten durch europäische Zentralisierung kompensiert werden solle, da dies zu einer unbeabsichtigten

Verschiebung der wirtschaftlichen Fähigkeiten führen könne. Zudem sei man nicht sicher, ob die geschäftlichen Interessen der Pharmaunternehmen immer erkannt werden könnten. Die deutsche Intervention habe dazu geführt, dass dieser Aspekt nun deutlich zurückhaltender verfolgt werde und nur noch für absolute Notfallsituationen in Betracht gezogen werde, beispielsweise um zentral Ausschreibungen und Preisverhandlungen für eine europaweite Versorgung mit bestimmten Arzneimitteln durchzuführen. Im Bereich der Präventionsmaßnahmen habe der Gesundheitskommissar angekündigt, eine Herz-Kreislauf-Strategie auf den Weg bringen zu wollen, was mit der deutschen, breiter gefassten Präventionsstrategie korrespondiere, die sich auf alle nicht übertragbaren Krankheiten beziehe. Dass im Zusammenhang mit dem Critical Medicine Act und den antimikrobiellen Resistenzen Wert auf das intellektuelle Eigentum und die Patentrechte gelegt werde, welche nicht beliebig zur Disposition gestellt werden dürften, sei zu begrüßen. Es gebe zudem Diskussionen um die Anreizwirkungen von Vouchers (Verkaufsgutscheine), die laut Krankenkassen zu einer erheblichen Verwerfung und Kostenexplosion führen könnten. Daher werde der Einsatz dieser Gutscheine begrenzt, um sie nicht für absolute Blockbuster einsetzen zu können. Die dänische Ratspräsidentschaft habe zudem grenzüberschreitende Studiendurchführung thematisiert. Dies sei besonders für seltene Erkrankungen interessant, da Patientenkohorten grenzüberschreitend besser erfasst werden könnten. Bei der September-Sitzung seien Vertreter der Europäischen Freihandelsassoziation (Schweiz, Norwegen, Island) sowie der Ukraine anwesend gewesen. Es habe einen persönlichen Austausch über die Hilfsleistungen für die Ukraine zum Wiederaufbau des Gesundheitsversorgungssystems gegeben. Thema sei auch die Stärkung der mentalen Gesundheit bei Kriegstraumata. Kürzlich sei auch der stellvertretende ukrainische Gesundheitsminister in Berlin gewesen, um einen Soldaten in der Charité zu besuchen. Er lobte die Zusammenarbeit über das Kleeblatt-System, wobei die Notwendigkeit der Hilfeleistung erneut sichtbar geworden sei.

Abg. **Sascha van Beek** (CDU/CSU) appelliert an die Ausschussmitglieder, bestehende Gelegenheiten zum direkten Austausch mit EU-Vertretern, etwa dem Kommissar und EU-Parlamentariern intensiver zu nutzen.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) fragt, was die Definition von Desinformation im Gesundheitswesen sei und inwieweit diese bekämpft werden solle.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass die Wirksamkeit eines Gesundheitssystems davon abhängt, dass alle Akteure mit wissenschaftlich fundierten Informationen sachgerecht umgehen könnten. Dies setze voraus, dass die Bevölkerung diese Informationen erhalte und den Unterschied zu Falschinformationen erkennen könne. Die genaue Definition von Begriffen wie Desinformation und Fehlinformation sei zwar allgemein noch eine Aufgabe für die Zukunft, im Gesundheitswesen herrschten jedoch bereits klare Verhältnisse. Da dieser Bereich auf einer fundierten wissenschaftlichen Basis stehe, sei es dort nicht nur möglich, sondern sogar verpflichtend, Informationen als falsch oder nicht zielführend zu kennzeichnen, sofern sie der überwiegenden Fachmeinung widersprächen und die Gesundheit der Bevölkerung gefährdeten.

Abg. **Thomas Dietz** (AfD) bemerkt, dass Wissenschaft Diskurs sei und der Diskurs auch stattfinden dürfe.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD) fragt, warum sich Deutschland an einer öffentlich-privaten Partnerschaft wie Trial Nation beteilige, bei der die Industrie maßgeblich mitwirke, und ob die Gefahr einer Einflussnahme durch Pharmaunternehmen bestehe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass Deutschland nicht an diesem dänischen Projekt beteiligt sei. Es sei lediglich als Modell vorgestellt worden, um möglicherweise in eigener Regie umgesetzt zu werden, aber zurzeit gebe es keine Kooperation.

Abg. **Joachim Bloch** (AfD) fragt, warum die Ukraine als Drittstaat an einem EU-Gesundheitsministertreffen teilnehme, unter welchem Mandat dies geschehe und welchen Einfluss dies auf die EU-Gesundheitsstrategie habe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass es sich um das Format des informellen Rates gehandelt habe, welches nicht den diplomatischen oder protokollarischen Vorschriften der EU-Ratspräsidentschaft entspreche. Die Teilnahme sei daher eine Gastrolle gewesen, und von Einfluss könne überhaupt keine Rede sein. Man habe sich formlos ausgetauscht und die Bedürfnisse und Feststellungen interessiert diskutiert.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, ob auch über die Auswirkungen der digitalen Beschulung gesprochen worden sei, da diese in Deutschland zunehme, aber in einigen nordischen Staaten gestoppt und zur herkömmlichen Beschulung zurückgekehrt werde.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass diese Fragestellung als Thema adressiert und als Arbeitsauftrag an die Mitgliedstaaten gegeben worden sei, jedoch nicht wissenschaftlich vertieft worden sei.

Abg. **Dr. Christina Baum** (AfD) fragt, ob von deutscher Seite Interesse bestehe, über die digitale Beschulung zu diskutieren.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) bejaht, dass wenn man sich mit der mentalen Gesundheit der Jugendlichen beschäftige, man sich zwangsläufig mit Umwelteinflüssen auseinandersetzen müsse. Er ergänzt, dass hierzu mittlerweile auch die digitale Möglichkeit der Kontaktaufnahme der jungen Generation in jedweder Form gehöre, was verantwortungsbewusst zu analysieren sei.

11:58 Uhr Übergabe der Sitzungsleitung an den stellvertretenden Vorsitzenden Abg. Dr. Pilsinger

Abg. **Serdar Yüksel** (SPD) nimmt Bezug auf die im Rat verabschiedeten Schlussfolgerungen zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im digitalen Zeitalter, welche auf Schutz, Prävention und Resilienzförderung abzielten. Er führt aus, dass hierfür in Deutschland eine



Nur zur dienstlichen Verwendung

Rahmensetzung nötig sei, insbesondere in Bezug auf Schule, Medienpädagogik, digitale Regulation und Jugendschutz. Er fragt, welche konkreten Maßnahmen die Bundesregierung zur Umsetzung dieser Schlussfolgerungen plane, und ob eine nationale Strategie angedachte sei.

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es müsse zunächst mit den anderen Fachbereichen wie Bildung, Schule und Kultur in den Austausch getreten werden, da die Umsetzung an die Hürden des Föderalismus stoße. Ziel sei es, aufeinander abgestimmte Regularien zu finden, ohne moderne Entwicklungen zu behindern. Er halte einen Austausch mit den europäischen Nachbarn für zielführend, um nicht das Rad neu erfinden zu müssen. Er betone, dass der Umgang mit digitalen Endgeräten zwar sinnvoll sei, aber kontrolliert ausgeübt werden müsse. Seine persönliche Ansicht sei, dass es sinnvoll wäre, eine nationale Strategie zu diesem Thema aufzulegen, um einen wissenschaftlichen Diskurs und eine Austauschplattform ins Leben zu rufen. Er sei überzeugt, dass es keine absolute Richtigkeit gebe und eine Entwicklung nötig sei.

Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonthier (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) gibt zunächst ihre Irritation über den Umgang des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) mit dem Ausschuss zu Protokoll. Sie führt aus, dass der Ausschuss vergeblich um die Auskunft der Ministerin zu Einsparideen und zur Stabilisierung der GKV-Finanzierung gebeten habe. Nun gebe die Ministerin parallel genau zu diesen Fragen eine Pressekonferenz, was sie als irritierenden Umgang mit dem Ausschuss beurteile, da diese Fragen weitreichende Konsequenzen für das deutsche Gesundheitssystem hätten. Sie fragt zum Thema seelische Gesundheit von Kindern im digitalen Zeitalter, ob es Initiativen von Deutschland gebe, die in die EU-Diskussion eingebracht würden, um zu einer weitergehenden Regulierung von Social-Media-Zugängen zu kommen, und wie der weitere Zeitplan sei.

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass das Internet Fluch und Segen zugleich sei. Er führt aus, dass telemedizinische Leistungen gerade bei mentalen

Belastungssituationen eine Beschleunigung des Therapiezugangs und eine Eigenreflexion im Vorfeld ermöglichen könnten. Ihm sei aufgrund seiner kurzen Amtstätigkeit noch kein Konzept aus dem Haus bekannt. Er habe aber auf europäischer Ebene vernommen, dass das Thema unterschiedlich priorisiert werde, die Länder aber akuten Handlungsbedarf sähen. Er hoffe, dass das Thema beim weiteren Austausch mit der dänischen Ratspräsidentschaft aufgerufen werde, und werde es auf jeden Fall auf die Agenda setzen.

Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonthier (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) fragt konkret nach der Verantwortung der Anbieter von Social-Media-Plattformen und dem weiteren Plan der Bundesregierung, im Zusammenschluss mit der EU, Anbieter zu entsprechenden Regulierungen zu verpflichten.

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass dies kein Thema seines Ressorts sei. Er mutmaßt, dass dies eher im Digital- oder Forschungsministerium thematisiert werde.

Abg. Dr. Kirsten Kappert-Gonthier (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nimmt Bezug auf die Berichterstattung, wonach die Europäer sich in den Tod tranken und Europa beim Alkohol eine Hochkonsumregion sei. Sie fragt nach verhältnispräventiven Ansätzen bezüglich Tabak und Alkohol, die auf europäischer Ebene diskutiert würden. Sie erkundigt sich, welche Ideen im Raum stünden, wie zum Beispiel die von der WHO vorgeschlagenen Werbeeinschränkungen oder Steuererhöhungen.

PStS Dr. Georg Kippels (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es sei keine Lösung priorisiert worden, sondern diese Themen würden in gewissen Abständen immer wieder auf ihre politische Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit hin überprüft. Er ergänzt, dass ein Erkenntniswandel festzustellen sei. Der Aspekt der Besteuerung oder eines Werbeverbots sei bei der Verhältnisprävention angesiedelt, wohingegen beides besser bei der Verhaltensprävention aufgehoben wäre, wobei geschaut werden müsse, wie dies kommunikativ ins System gebracht werde.



Nur zur dienstlichen Verwendung

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) schließt sich der Kritik von Abg. Dr. Kappert-Gonthier zur Pressekonferenz der Ministerin an, zumal der vorherige Minister bereits kritisiert worden sei, dass sein Sendungsbewusstsein nach außen größer gewesen sei als die Präsenz im Ausschuss. Er bittet darum, diese Kritik weiterzugeben, da ein solches Vorgehen, vor allem nicht zur selben Uhrzeit, wenn die Ministerin eigentlich im Ausschuss sein könnte, nicht akzeptiert werden könne.

Er fragt, wie die Bundesregierung zu einheitlichen oder länderübergreifenden Arzneimittelbeschaffungen stehe, da in Deutschland jedes Krankenhaus oder Unternehmen die Arzneimittel selbst bezahle und unterschiedliche Kosten habe.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, dass er dies bereits kritisch thematisiert habe.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) hakt nach, aus welchen Gründen dies kritisch beurteilt werde, da es mit Marktmacht zu tun habe und diese auf europäischer Ebene erhöht werden könne.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) führt aus, dass die Frage, wie auf europäischer Ebene stellvertretend für Mitgliedstaaten Ausschreibungen und Verhandlungen stattfinden, entscheidend davon abhängen, was in den Ländern umgesetzt werden könne. Es müssten mehrere Stellschrauben harmonisiert werden, beispielsweise ob für 27 Mitgliedstaaten und wenn ja, in welcher Menge eingekauft werde. Es müsse geklärt werden, ob stellvertretend für die Käufer verhandelt werde oder ob der Einkauf komplett aus EU-Mitteln finanziert werde. Er sehe beide Positionen äußerst kritisch, da er dies nicht als Aufgabe der EU sehe, keinen zwangsläufig positiven Vereinheitlichungseffekt erwarte und die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedstaaten im Gesundheitssektor nicht zentral abbildbar seien. Jedes Mitgliedsland habe seine eigene gesundheitliche Strategie.

Abg. **Ates Gürpınar** (Die Linke) entgegnet, dass es in allen Nationen Herz-Kreislauf, Krebs und Diabetes gebe und der Kommissar ja sogar eine Strategie dazu angekündigt habe.

Er fragt zu den Lieferengpässen, ob die Regierung etwas an der fehlenden gesetzlichen Meldepflicht oder der automatisierten Erfassung ändern wolle, um dann im nächsten Schritt Lieferengpässe auch auf EU-Ebene darstellen zu können.

PStS **Dr. Georg Kippels** (Bundesministerium für Gesundheit (BMG)) antwortet, es sei die spannende Frage, ob es wirklich objektive Lieferengpässe der Industrie gebe oder ob es ein Verteilungs- beziehungsweise Logistikproblem sei. Er führt aus, dass in der Vergangenheit in Gesprächen mit dem Beirat des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) über Erfassungsmöglichkeiten nachgedacht worden sei. Er habe durch persönliche Gespräche mit dem Großhandel erfahren, dass es dort bereits einen relativ guten Überblick gebe, auch wenn dieser nicht öffentlich einsehbar sei. Man müsse sich damit auseinandersetzen, wobei die europäischen Länder nicht die gleichen Vorstellungen und strukturellen Voraussetzungen hätten.

Schluss der Sitzung: 12:15 Uhr

gez.

Dr. Tanja Machalet, MdB
Vorsitzende

Dr. Stephan Pilsinger, MdB
Stellvertretender Vorsitzender

Anlagenkonvolut zum Kurzprotokoll der 13. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 15. Oktober 2025

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Änderungsanträge**der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit**

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 – HG 2026)
(21/600)

Änderungsantrag 1**Deutscher Pflegerat**

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
12	Kapitel 1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung <u>Titel 684 08 - 314</u> Projekte und Maßnahmen des Deutschen Pflegerats (DPR) zur Stärkung der Berufsgruppe der Pflegekräfte 900 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben für den Deutschen Pflegerat geleistet werden.	Kapitel 1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung <u>Titel 684 08 - 314</u> Projekte und Maßnahmen des Deutschen Pflegerats (DPR) zur Stärkung der Berufsgruppe der Pflegekräfte 1 800 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben für den Deutschen Pflegerat geleistet werden.	+ 900	Die zusätzlichen Mittel sollen zur angemessenen finanziellen Ausstattung des Deutschen Pflegerats (DPR) bereitgestellt werden, damit dieser seine im aktuell im parlamentarischen Verfahren befindlichen Gesetz „Gesetz zur Befugnisenerweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ vorgesehene Rolle als maßgebliche Organisation der Pflegeberufe wahrnehmen kann. Nur so können die gesetzlichen Beteiligungsrechte nach dem Fünften und Elften Buch SGB sachgerecht umgesetzt und die erforderlichen personellen Strukturen aufgebaut werden.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Änderungsantrag 2

Gesundheitliche Aufklärung und Prävention

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
17	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 01 - 314</u> Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung 24 421 Verpflichtungsermächtigung 22 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 7 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01. 2. Rückzahlungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. Erläuterungen:	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 01 - 314</u> Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung 27 421 Verpflichtungsermächtigung 22 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 7 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01. 2. Rückzahlungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. Erläuterungen:	+ 3 000 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die Mittel sollen zur Stärkung der gesundheitlichen Aufklärung und Prävention eingesetzt werden. Dabei sollen insbesondere die Kürzungen in zentralen Bereichen wie der Organspende, der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie der Gesundheitsförderung im Alter – und weiteren wichtigen Präventionsfeldern – zurückgenommen werden. Ein besonderer Schwerpunkt muss zudem auf der Suizidprävention liegen. Der Deutsche Bundestag hat sich bereits für die Einführung eines Suizidpräventionsgesetzes ausgesprochen, weshalb Suizidprävention künftig eine zentrale Rolle in den Präventionsmaßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit einnehmen muss.
	Bezeichnung 1 000€	Bezeichnung 1 000€		

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	1. Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 2 236 2. Aufklärung zur Organ- und Gewebespende 5 058 3. Motivationskampagne zur Blut- und Plasmaspende 246 4. Gesundes Alter 1 147 5. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 1 843 6. Erhöhung der Reichweiten 1 024 7. Infektionsschutz (Impfen, Hygiene, Krisenkommunikation) 5 078 8. Stärkung der Laienreanimation 387 9. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität - Informations- und Beratungsangebot zum Schutz vor Konversionsbehandlungen 352 10. Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 187 11. Nationaler Präventionsplan 1 764 12. Long-Covid Beratung 200 13. Diabetes mellitus und andere nicht übertragbare Krankheiten (NCD) 899 14. Begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform 4 000	1. Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 2 600 2. Aufklärung zur Organ- und Gewebespende 5 880 3. Motivationskampagne zur Blut- und Plasmaspende 286 4. Gesundes Alter 1 333 5. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 2 143 6. Erhöhung der Reichweiten 1 190 7. Infektionsschutz (Impfen, Hygiene, Krisenkommunikation) 5 904 8. Stärkung der Laienreanimation 450 9. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität - Informations- und Beratungsangebot zum Schutz vor Konversionsbehandlungen 409 10. Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 217 11. Nationaler Präventionsplan 850 12. Long-Covid Beratung 200 13. Diabetes mellitus und andere nicht übertragbare Krankheiten (NCD) 1 045 14. Begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform 4 000 15. Suizidprävention 914		

Änderungsantrag 3

Drogen- und Suchtprävention

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
19	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 03 - 314</u> Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 14 102 Verpflichtungsermächtigung 12 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 5 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 4 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 3 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Rückzahlungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. In Ausführung des Aktionsplanes Drogen und Sucht soll die Aufklärung durch massen- und personalkommunikative Maßnahmen zielgruppenorientiert fortgesetzt werden.	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 03 - 314</u> Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 19 102 Verpflichtungsermächtigung 12 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 5 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 4 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 3 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Rückzahlungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. In Ausführung des Aktionsplanes Drogen und Sucht soll die Aufklärung durch massen- und personalkommunikative Maßnahmen zielgruppenorientiert fortgesetzt werden.	+ 5 000 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen zur Stärkung der Prävention im Bereich des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs eingesetzt werden, insbesondere zur Aufklärung über die Gefahren von Methamphetamin. Eine Anhebung des Ansatzes auf das Niveau von 2024 ist erforderlich, da der aktuelle Ansatz den tatsächlichen Bedarf nicht widerspiegelt.

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	2. Die Mittel werden überwiegend dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zur Bewirtschaftung zugewiesen.	2. Die Mittel werden überwiegend dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zur Bewirtschaftung zugewiesen. 3. Insbesondere Aufklärungsmaßnahmen zum Missbrauch von Methamphetaminen ("Crystal Meth") sollen finanziell gestärkt werden.		

Änderungsantrag 4

Patientensicherheit

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
20	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 684 02 - 314</u> Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit 4 000 Verpflichtungsermächtigung 2 400 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 1 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 900 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 500 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden.	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 684 02 - 314</u> Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit 4 500 Verpflichtungsermächtigung 2 400 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 1 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 900 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 500 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden.	+ 500 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen für eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Sepsisprävention eingesetzt werden. Ziel ist es, das Wissen über Frühsymptome, die Notwendigkeit der schnellen Behandlung sowie Präventionsmaßnahmen wie Impfungen, Hygieneregeln und die konsequente Behandlung von Infektionen zu stärken, um Sepsissterbefälle deutlich zu reduzieren.

Änderungsantrag 5

Nationales Gesundheitsportal

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
21	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 686 01 - 314</u> Nationales Gesundheitsportal 1 850 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu 700 <u>Haushaltsvermerk</u> Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 686 01 - 314</u> Nationales Gesundheitsportal 1 950 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu 700 <u>Haushaltsvermerk</u> Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	+ 100 (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen bereitgestellt werden, um den Bundes-Klinikatlas weiterzuführen und seine Qualität zu verbessern. Eine finanzielle Schwächung des Projekts wäre aus Patient*innensicht ein fatales Signal, da Transparenz und Vergleichbarkeit in der Krankenhausversorgung gestärkt statt behindert werden müssen.

Änderungsantrag 6

Stärkung der internationalen Gesundheit

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
43	Kapitel 1505 Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 686 01 - 314</u> Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit 55 880 Verpflichtungsermächtigung 30 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 15 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden kann, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die multilaterale Zusammenarbeit, an der Deutschland ein besonderes gesundheitspolitisches Interesse hat, wie die Förderung von Vorhaben internationaler Organisationen oder Initiativen, die Ausrichtung von oder die Beteiligung an internationalen Konferenzen und Workshops mit der Zielsetzung, die internationale öffentliche	Kapitel 1505 Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 686 01 - 314</u> Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit 62 630 Verpflichtungsermächtigung 30 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 15 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden kann, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die multilaterale Zusammenarbeit, an der Deutschland ein besonderes gesundheitspolitisches Interesse hat, wie die Förderung von Vorhaben internationaler Organisationen oder Initiativen, die Ausrichtung von oder die Beteiligung an internationalen Konferenzen und Workshops mit der Zielsetzung, die internationale öffentliche	+ 6 750 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um die Kürzung im Titel zur Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit von rund 3,5 Millionen Euro zurückzunehmen und gleichzeitig durch weitere Mittel die internationale Gesundheit zu stärken. Dadurch kann Deutschlands Verantwortung auf globaler Ebene gestärkt und den negativen Folgen des teilweisen Rückzugs anderer Länder aus der WHO-Finanzierung entgegengewirkt werden. Davon profitieren auch wichtige internationale Gesundheitsinitiativen wie die WHO und UNAIDS, die maßgeblich zur globalen Gesundheitsvorsorge und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beitragen.

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	Gesundheit zu stärken. Hier liegt der Fokus insbesondere auf der WHO als die für internationale öffentliche Gesundheit zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (VN). Weiterhin dienen die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Finanzierung von spezialisierten Maßnahmen der internationalen Gesundheitssicherheit. Hierfür wird Schlüsselexpertise aus Deutschland, insbesondere aus den Fachinstitutionen des BMG genutzt, die zugleich für die jeweiligen Themen auch national zuständig sind. Diese Expertise stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches in dieser Form nur im BMG mit seinem Geschäftsbereich vorhanden ist. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt vor allem auf der Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Eindämmung des Ausbruchs und der Verhinderung der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Infektionskrankheiten, einschließlich solcher mit antimikrobiellen Resistenzen. Zur Erreichung der genannten Zwecke kann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen, insbesondere Public Health Institutionen im globalen Süden erfolgen, um deren Fähigkeiten zur eigenständigen Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zu stärken. Die Zusammenarbeit kann auch eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die Ausbildung von Personal der Partnerstaaten sowie Unterstützungsleistungen im Bereich der epidemiologischen Lage- und Risikobewertung und des Krisenmanagements umfassen.	Gesundheit zu stärken. Hier liegt der Fokus insbesondere auf der WHO als die für internationale öffentliche Gesundheit zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (VN). Weiterhin dienen die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Finanzierung von spezialisierten Maßnahmen der internationalen Gesundheitssicherheit. Hierfür wird Schlüsselexpertise aus Deutschland, insbesondere aus den Fachinstitutionen des BMG genutzt, die zugleich für die jeweiligen Themen auch national zuständig sind. Diese Expertise stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches in dieser Form nur im BMG mit seinem Geschäftsbereich vorhanden ist. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt vor allem auf der Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Eindämmung des Ausbruchs und der Verhinderung der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Infektionskrankheiten, einschließlich solcher mit antimikrobiellen Resistenzen. Zur Erreichung der genannten Zwecke kann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen, insbesondere Public Health Institutionen im globalen Süden erfolgen, um deren Fähigkeiten zur eigenständigen Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zu stärken. Die Zusammenarbeit kann auch eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die Ausbildung von Personal der Partnerstaaten sowie Unterstützungsleistungen im Bereich der epidemiologischen Lage- und Risikobewertung und des Krisenmanagements umfassen.		
	2. Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.	2. Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.		
	3. Für UNAIDS werden aus diesem Titel Mittel in Höhe von 6 750 T€ bereitgestellt.	3. Für UNAIDS werden aus diesem Titel Mittel in Höhe von 10 000 T€ bereitgestellt.		

Änderungsantrag 7

Beiträge an internationale Organisationen

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
44	<u>Kapitel 1505</u> Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 687 01 - 314</u> Beiträge an internationale Organisationen 39 334	<u>Kapitel 1505</u> Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 687 01 - 314</u> Beiträge an internationale Organisationen 49 334	+ 10 000	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um Deutschlands internationale Verantwortung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu übernehmen und ein deutliches Signal zu setzen. Sie dienen der Förderung multilateraler Zusammenarbeit, etwa durch Vorhaben internationaler Organisationen, Beteiligung an Konferenzen und Workshops, und stärken gezielt die WHO als zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Eine Erhöhung der deutschen Pflichtbeiträge würde zudem andere Länder in die Verantwortung ziehen und den internationalen Organisationen maximalen Nutzen bringen.

Änderungsantrag 8

Geschäftsbereich BIÖG

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
71	Kapitel 1513 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit <u>Titel 511 01 - 314</u> Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 1 671	Kapitel 1513 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit <u>Titel 511 01 - 314</u> Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 671	+ 2 000	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) angemessen auszustatten und seine vielfältigen Aufgaben in gesundheitlicher Aufklärung, Prävention, Gesundheitsförderung und Infektionsschutz wirksam wahrnehmen zu können. Prävention ist ein zentraler Baustein einer zukunftsfähigen Gesundheitspolitik und muss stärker als bisher in den Fokus rücken. Mit dem neu geschaffenen Institut besteht die Chance, die Präventionsarbeit in Deutschland strategisch zu bündeln, wissenschaftlich zu fundieren und sichtbarer zu machen. Es darf nicht dabei bleiben, dass die bisherige Arbeit der BZgA lediglich unter neuem Namen fortgeführt wird – das BIÖG muss vielmehr zu einer modernen, leistungsfähigen Einrichtung weiterentwickelt werden, die neue Impulse für eine umfassende und wirksame Gesundheitsförderung setzt und zugleich aktuelle Aufgaben, wie begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform, gezielt unterstützt.



Betrifft:

Stellungnahme von Dr. Daniel Vilser für den Ärzte und Ärztinnenverband Long Covid zum Fachgespräch "Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen"

Ausschuss für Gesundheit in seiner Sitzung am Mittwoch, den 15. Oktober 2025

Sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses,

postakute Infektionserkrankungen (PAIS), zu denen Long-Covid und ME/CFS zählen, sind klinisch relevante, oft fluktuierende, infektionsassoziierte Langzeiterkrankungen mit erheblicher Alltags- und Teilhabebeeinträchtigung. 3–6% aller mit SARS-CoV-2 infizierten Erwachsenen haben über die akute Infektion hinaus mit Problemen zu kämpfen. Kinder und Jugendliche sind etwas seltener betroffen.

Neben dem persönlichen Leid der Betroffenen ist die finanzielle Belastung der Gesellschaft enorm. Die jährlichen Gesamtkosten, unter anderem aus Produktivitätsverlusten, Arbeitgeber- sowie Gesundheitsausgaben, betrugen 2024 geschätzte 63,1 Milliarden Euro.

Die Schwierigkeit in der Diagnostik besteht darin, dass PAIS kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern verschiedene Pathomechanismen zu dem desaströsen Zustand der Patienten führen können. Auch wenn die Forschung in den letzten Jahren bereits erhebliche Fortschritte bei der Identifizierung dieser Vorgänge gemacht hat, existiert derzeit weder ein einzelner Biomarker noch ein spezifischer Test, der die Diagnose PAIS oder ME/CFS zweifelsfrei sichern kann.

Therapeutisch sind kausale medikamentöse Verfahren bislang nicht gesichert, allerdings haben wir Fortschritte bei der Behandlung einzelner Symptome gemacht.

Was braucht es von der Politik:

Flächendeckende, verlässlich finanzierte interdisziplinäre Versorgungsstrukturen – inklusive pädiatrischer Angebote – mit klaren Überweisungspfaden, PEM-sensiblen Reha-Konzepten und arbeitsmedizinischer Reintegration. Ein Beispiel dafür könnte das Projekt Pednet sein, welches für Kinder und Jugendliche ein solches Versorgungsnetzwerk geschaffen hat und die Basis für weitere Forschung liefert. Essenziell ist, dass solche Strukturen, die mit erheblichem Aufwand etabliert wurden, auch weiter finanziert werden. Während die Betreuung der Erkrankten in die perspektivisch in die Regelversorgung übergehen sollte bleibt die Finanzierung der so wichtigen begleitenden Forschung Aufgabe der Bundesregierung und spezieller Fördervorhaben.

Eine mehrjährige Forschungs- und Innovationsoffensive (biomedizinische Mechanismen, stratifizierende Endotypen, Register/Kohorten, Biobanken) und verbindliche randomisierte, qualitätsgesicherte Therapiestudien. Ein besonderer Fokus ist hierbei auf Kinder und Jugendliche zu legen, weil Kinderärzte aktuell fast ausschließlich im „Off-Label“-Bereich agieren.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Sozial- und arbeitsrechtliche Klarheit herstellen (leistungsrechtliche Zugänge, Stufen-Wiedereingliederung, Nachteilsausgleich, Homeoffice, alternative Schulkonzepte).

Eine bundesweite, zielgruppenspezifische Aufklärungsoffensive, die unsichtbare Krankheitsverläufe sichtbar macht, Fehlwahrnehmungen korrigiert und Stigmatisierung abbaut. Weil Long-Covid und ME/CFS Erkrankte häufig keine äußerlich erkennbaren Anzeichen zeigen, werden Betroffene noch zu oft missverstanden, bagatellisiert oder benachteiligt – dem ist durch klare, evidenzbasierte Information und praxisnahe Handreichungen für Schulen, Betriebe und Verwaltungen entgegenzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniel Vilser
Vizepräsident ÄLC
Chefarzt
Kinderkliniken Ingolstadt/Neuburg
AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg

Literatur:

BFARM, Therapiekompass abgerufen am 9.10. unter [BfArM - Expertengruppe Long COVID Off-Label-Use](#)

Daniell, J.....The rising cost of Long COVID and ME/CFS in Germany Mai2025 abgerufen am 9.10.2025 unter [The-rising-cost-of-Long-COVID-and-MECFS-in-Germany.pdf](#)

Koczulla, A. R.... S1-Leitlinie post-COVID/long-COVID. 30.05.2024 abgerufen 9.10.2025 unter: [020-027p1_S1_Post_COVID_Long_COVID_2025-08-verlaengert.pdf](#)

Schmidt, J., Töpfner, N., Vilser, D., Storm van's Gravesande, K., Oftring, Z., Soler Wenglein, J., ... & Behrends, U. (2025). Postakute Infektions-und Vakzinierungssyndrome bei Kindern und Jugendlichen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 1-7.



15. Oktober 2025

Stellungnahme zum Fachgespräch: „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, 15.10.2025 um 09:30 Uhr

Mündliche Stellungnahme

Sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrte Sachverständige,

ich bedanke mich herzlich für die Einladung und gehe kurz auf einige Aspekte ein, die aus Sicht von Menschen, die mit Long COVID und ME/CFS leben, besonders hervorzuheben sind.

Unverändert bestehen Barrieren, die einer flächendeckenden medizinischen und sozialen Versorgung im Wege stehen. Hausarztpraxen sind in der Regel nicht für die ausführliche Diagnostik bei diesen komplexen Krankheiten ausgestattet. Der diagnostische und therapeutische Aufwand wird unzureichend über die aktuellen EbM-Ziffern abgedeckt. Die allgemeine kassenärztliche Versorgung, wie vom G-BA vorgesehen, funktioniert oft nicht. Vielen Versorgenden fehlt es schlicht an Wissen über die Erkrankungen. Aufgrund mangelnder Erfahrungen verschreiben viele Hausärztinnen so auch keine Off-Label-Medikamente. Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Etablierung von Kompetenzzentren bzw. Schwerpunktpraxen, so wie diese in Rheinland-Pfalz initiiert wurden. Sowie die Etablierung von strukturierten und standardisierten Behandlungsprogrammen.

Besonders gravierend ist die Lage für Menschen mit schwerer Krankheit, die in der Regel keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung haben, weder im Klinik- noch im Praxissetting. Neupatientinnen müssen mit langen Wartezeiten rechnen. Die Versorgung mit Hilfsmitteln und die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit, notwendiger Assistenz oder Schwerbehinderung ist in der Regel erst durch Widerspruch oder Klage zu erreichen.

Frühzeitige Diagnostik und symptomorientierte Behandlung könnten möglicherweise bei vielen Betroffenen ein schweres Erkrankungsstadium mit vollständiger Erwerbsunfähigkeit verhindern. Reha-Maßnahmen können bei den meisten Patient*innen im bestmöglichen Fall maximal zu einem besseren

Krankheitsmanagement verhelfen, heilen jedoch nicht die zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen. Die medikamentöse Therapie muss daher zum zentralen Baustein der Versorgung werden. In diesem Kontext sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Empfehlungen der Expertinnengruppe Long COVID Off-Label-Use in die flächendeckende Umsetzung zu bringen.

Aus Sicht der Betroffenen ist die Medikamentenforschung – im Off-Label-Bereich sowie an neuen Präparaten – das erfolgversprechendste Mittel zur Bekämpfung von Long COVID und ME/CFS. Wir fordern daher die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Therapievorhaben in Deutschland, Förderrichtlinien für klinische Therapiestudien mit begleitender Biomarkerforschung, sowie die langfristige und angemessene Förderung von zentralen Therapieplattformen wie der Nationalen Klinischen Studiengruppe und dem Netzwerk Universitätsmedizin. Seitens der Politik sollten zudem Anreize geschaffen werden, damit es zeitnah zu einer Beteiligung der pharmazeutischen Industrie an der Therapieforschung kommt. Ein vom BMG- und BMFTR-initiiertes Pharma-Roundtable zu Long COVID und ME/CFS könnte hierfür eine mögliche Maßnahme sein.

Schätzungsweise leben in Deutschland rund 1,5 Mio. Menschen mit Long COVID oder ME/CFS. Beide Erkrankungen verursachten im Jahr 2024 geschätzte Kosten in Höhe von 63 Mrd. Euro. Demgegenüber stehen Investitionen der Bundesregierung in die Therapie, Biomarker, - und Diagnostikforschung in Höhe von ca. 15 Mio. € jährlich. Gerade auch aufgrund der geschilderten Erfahrungen der Betroffenen plädieren wir daher eindringlich für eine deutliche Aufstockung der Fördermittel für die Grundlagen- und Therapieforschung.

Vielen Dank.

Fachgespräch „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“

PD Dr. Dr. Bettina Hohberger

@Dr_B_Hohberger

Anlage 4	Deutscher Bundestag Ausschuss f. Gesundheit
	Ausschussdrucksache 21(14)29 gel. SV zur 13. Sitzung am 15.10.2025 - TOP 8 14.10.2025

Im Ausschuss für Gesundheit
am Mittwoch, den 15. Oktober 2025
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3 101



Friedrich-Alexander-Universität
Medizinische Fakultät

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

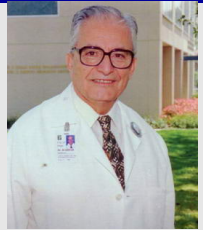
Augenklinik, Direktor: Prof. F.E. Kruse
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen

**Uniklinikum
Erlangen**



Diabetes

Ein Beispiel für einen Siegeszug in der Medizin



Samuel Rahbar

„Zufalls“-Befund

Bestätigung des „Zufalls“-Befundes

Aufbau des Biomarkers & Diagnostikums

Verifizierung des Biomarkers unter Therapie

Clin. Chim. Acta, 22 (1968) 296–298

An abnormal hemoglobin in red cells of diabetics

In a survey carried out on 1200 patients from Tehran University Hospitals, in addition to three rare hemoglobins which are under investigation both in our department here and at the University of Cambridge, two patients also showed an abnormal fast moving hemoglobin fraction; both were suffering from diabetes mellitus.

Verifizierung in 47 weiteren Blutproben von Diabetikern

Aufbau/Optimierung der Labormethode zur optimalen Bestimmung der **neuen Bande (HbA1c)**

Bestätigung der Befunde mit der neuen Labormethode in einem anderen Labor

Correlation of Glucose Regulation and Hemoglobin A_{1c} in Diabetes Mellitus

We studied the increased levels of hemoglobins A_{1a+1b} and A_{1c} in five hospitalized diabetic patients to determine whether changes in diabetic control would cause parallel changes in the levels of these hemoglobins. Before control of diabetes the mean fasting blood sugar for all patients was 343 mg per deciliter (range, 280 to 450), and hemoglobin A_{1c} concentration 9.8 per cent (range, 6.8 to 12.1). During optimal diabetic control the blood sugar concentration was 84 mg per deciliter (range, 70 to 100), and hemoglobin A_{1c} concentration 5.8 per cent (range, 4.2 to 7.6). Hemoglobin A_{1c} concentration appears to reflect the mean blood sugar concentration best over previous weeks to months. The periodic monitoring of hemoglobin A_{1c} levels provides a useful way of documenting the degree of control of glucose metabolism in diabetic patients and provides a means whereby the relation of carbohydrate control to the development of sequelae can be assessed. (N Engl J Med 295:417–420, 1976)

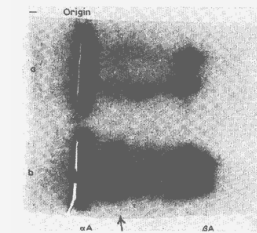


Fig. 4. Starch gel electrophoresis of PCMB-treated hemoglobins. a: normal; b: diabetic. Note the existence of an additional band faster than αA ($\uparrow$).

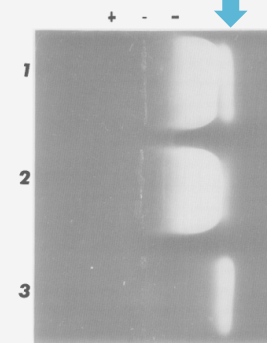


Fig. 1
Agar gel electrophoresis, pH 6.2, 0.05M citrate buffer. (1) Hemolysate from diabetic. (2) Hemolysate from normal. (3) Purified Hb A_{1c}.

Post-COVID Syndrom & ME/CFS

Der Beginn eines Siegeszuges in der Medizin

„Zufalls“-Befund



Viele Biomarker-Kandidaten für Post-COVID Syndrom (PCS) & ME/CFS



Bestätigung des „Zufalls“-Befundes



Biomarker-Kandidaten für Untergruppen der Patienten mit PCS / ME/CFS

Aufbau des Biomarkers & Diagnostikums

BMBF/BMG geförderten Forschungsvorhaben (aktuell laufend):

u.a.

- Aufbau von spezifischen Biomarkern & Biosignaturen für PCS & ME/CFS-Subgruppen
- Aufbau von Diagnostika



Verifizierung des Biomarkers unter Therapie

BMBF/BMG geförderte Forschungsvorhaben (*Bedarf*):

u.a.

- ***Validierung der spezifischen Biomarker & Biosignaturen für die PCS & ME/CFS-Subgruppen innerhalb Therapiestudien***



**Spezifische Therapien für spezifische Untergruppen von PCS & ME/CFS
(diagnostiziert anhand der Biomarker/Biosignaturen)**

